

Hemşirelik Soru Bankası

3679 SORULUK DEV KAYNAK



Hazırlayan: Musa Akat

© 2025 Musa Akat – Kendi Yayınıdır

Hemşirelik Soru Bankası

3679 SORULUK DEV KAYNAK

Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın hiçbir bölümü, yazarın yazılı izni olmaksızın fotokopi, dijital kopyalama, tarama, çoğaltma, basım veya elektronik ortamda paylaşım yoluyla kopyalanamaz ve dağıtılamaz.

ISBN: 978-625-00-6555-6

Yazar: Musa Akat

Kapak Tasarımı: Musa Akat

Yayıncı: Kendi Yayını

1. Baskı : 2025

2. Baskı (Gözden Geçirilmiş) : 2026

Kitap hakkında güncel bilgi için:
<https://hacvesaglik.blogspot.com>

Hemşirelik Soru Bankası

3679 Soruluk Dev Kaynak (440 Sayfa)

Bu kitap, özellikle **Hac Sağlık Sınavına** hazırlanan hemşireler için hazırlanmıştır. Neredeyse tüm konuları kapsayan, güncel ve özgün bir kaynak olma özelliği taşır.

İçerisinde;

Temel Hemşirelik bilgileri (492 soru),

Dahiliye Hemşireliği (875 soru),

Cerrahi (683 soru),

Yoğun Bakım ve Acil Hemşireliği (448 soru),

Çocuk Hastalıkları (326 soru),

Psikiyatri (336 soru),

Toplum Sağlığı Hemşireliği (107 soru),

Kadın ve Doğum (80 soru),

Farmakoloji (210 soru),

Araştırma ve Yönetim (122 soru)

olmak üzere toplam **3679** adet soru/cevap/açıklama mevcuttur.

Hac sağlık sınavı artık **üniversite bazında yapılacağı için**, kitapta yer alan sorular **lisans düzeyinde** hazırlanmıştır.

İÇİNDEKİLER

Önsöz.....	I
İçindekiler.....	II-III

1. Temel Hemşirelik Bilgileri.....	1
• Hemşireliğe giriş, temel kavramlar	3
• Sağlık-hastalık tanımları	15
• Hasta hakları, etik ilkeler	23
• Hemşirelik süreci	31
• Bireysel hijyen ve bakım	41
• Enfeksiyon kontrolü ve izolasyon	45
• Yaşam bulguları ölçümü	53
• Sterilizasyon ve dezenfeksiyon	57
2. İç Hastalıkları Hemşireliği (Dahiliye).....	61
• Kardiyovasküler sistem	63
• Solunum sistemi	85
• Endokrin	97
• Gastrointestinal sistem	109
• Hematoloji ve onkoloji	121
• Böbrek ve üriner sistem	135
• Bulaşıcı hastalıklar	149
3. Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği	157
• Preop, İntraop, Postop	159
• Yara, Drenler, Stoma	175
• Yanık ve Travma	189
• Genel Cerrahi	197
• Ortopedi Cerrahisi	211
• Cerrahi Branşlar	
o Göğüs Cerrahisi	219
o Kardiyovasküler Cerrahi	220
o Nöroşirurji	222
o Üroloji	225
o Göz	226
o Kulak Burun Boğaz	227
o Plastik Cerrahi	229
o Pediatrik Cerrahi	230
• Sıvı-elektrolit, Transfüzyon, Enfeksiyon	233
4. Yoğun Bakım ve Acil Hemşireliği	239
• Kardiyak Arrest – CPR - TYD & İYD	241
• Şok, Travma, Acil Bakım	251
• Hasta Güvenliği	263
• Mekanik Ventilator & Monitörizasyon	269
• Organ Destek Tedavileri	277
• Özel Durumlar & Etik	289
5. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (Pediatri)	293
• Yenidoğan	295
• Büyüme ve gelişme	305
• Çocukluk çağı enfeksiyonları	313
• Kronik hastalıklar	317
• Çocuk acil ve yoğun bakım	323
• Aşılar ve bağışıklama	329

6. Psikiyatri Hemşireliği	333
• Ruh sağlığına giriş	335
• Depresyon, anksiyete, bipolar	339
• Şizofreni ve psikotik bozukluklar	347
• Yaşlı Psikiyatrisi	355
• Çocuk Psikiyatrisi	359
• Bağımlılık	365
• Kriz müdahalesi	370
7. Toplum Sağlığı Hemşireliği (Halk Sağlığı)	375
• Sağlık politikaları, sistemler	377
• Aile sağlığı ve evde bakım	378
• Epidemiyoloji	379
• Koruyucu sağlık hizmetleri	380
• Çevre sağlığı	382
• Okul sağlığı hemşireliği	383
• Küresel sağlık sorunları ve programlar	385
• Toplum Sağlığı Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar ve Özel Alanlar	387
8. Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliği	389
• Üreme sağlığı	391
• Gebelik fizyolojisi ve takibi	392
• Normal doğum ve komplikasyonlar	394
• Sezaryen sonrası bakım	396
• Lohusalık ve yenidoğan	397
• Jinekolojik hastalıklar	398
9. Hemşirelikte Farmakoloji	399
• İlaç uygulama yolları	401
• Uygulama Öncesi Dikkat Edilecekler	403
• İlaç Hazırlama ve Aseptik Teknik	404
• İlaç etkileşimleri	405
• Özel Gruplar	407
• Antibiyotik grupları ve Hemşirelik Sorumlulukları	408
• Analjezikler	410
• Kardiyovasküler İlaçlar	412
• Yan etkiler ve Advers Reaksiyolar	414
• İlaç Hataları ve Güvenli Uygulama	416
• Güvenli ilaç uygulama protokolleri	418
• Ek Konular:	420
10. Hemşirelikte Araştırma ve Yönetim	421
• Araştırma yöntemleri	423
• Kanıta dayalı hemşirelik	425
• İstatistik temel kavramlar	427
• Liderlik ve yönetim	429
• Sağlıkta kalite ve akreditasyon	431
• Hemşirelikte araştırma, etik ve yönetim uygulamaları	433

ENFEKSİYON KONTROLÜ VE İZOLASYON

1. Soru

Enfeksiyon zincirinde “enfeksiyon etkeni” aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Bakteri, virüs, mantar gibi mikroorganizmalar
- B) Hasta bireyin bağışıklık sistemi
- C) Kullanılan steril malzeme
- D) Bağışıklık sistemi zayıf bireyler
- E) Sağlık çalışanlarının eldiven kullanımı

Cevap: A) Bakteri, virüs, mantar gibi mikroorganizmalar

Açıklama: Enfeksiyon zincirinin ilk halkası enfeksiyon etkeni olup genellikle bakteri, virüs, parazit ve mantarlar bu gruba girer.

2. Soru

Aşağıdakilerden hangisi enfeksiyon zincirini önlemede uygulamaya dönük en etkili yöntem nedir?

- A) Hasta odalarının sık havalandırılması
- B) El hijyeninin sağlanması
- C) Hastanın izolasyona alınması
- D) Atıkların yakılması
- E) Maske takılması

Cevap: B) El hijyeninin sağlanması

Açıklama: El hijyeni, enfeksiyon bulaşını önlemede en etkili ve temel yöntemdir.

3. Soru

Aşağıdakilerden hangisi yüksek düzey dezenfeksiyon yöntemine örnektir?

- A) Kaynatma
- B) Sabunla yıkama
- C) Alkolle silme
- D) Glutaraldehit kullanımı
- E) Sıcak su ile durulama

Cevap: D) Glutaraldehit kullanımı

Açıklama: Yüksek düzey dezenfeksiyon, sporlar hariç tüm mikroorganizmaları yok eder. Glutaraldehit ve orto-ftalaldehit (OPA) bu amaçla kullanılır.

4. Soru

Aşağıdakilerden hangisi dezenfeksiyonun özelliğidir?

- A) Sporları da yok eder
- B) Canlı dokularda uygulanabilir
- C) Mikroorganizmaların tümünü ortadan kaldırır
- D) Ciltteki normal florayı da yok eder
- E) Yüzey ve araçlarda uygulanır

Cevap: E) Yüzey ve araçlarda uygulanır

Açıklama: Dezenfeksiyon, cansız yüzeylerde patojenlerin büyük çoğunluğunu ortadan kaldırır ancak sporları yok etmez.

5. Soru

Aşağıdaki el yıkama türlerinden hangisi ameliyathane girişinde uygulanır?

- A) Sosyal amaçlı el yıkama
- B) Hijyenik el yıkama
- C) Cerrahi el yıkama
- D) El antisepsisi olmadan el yıkama
- E) Kısa süreli el yıkama

Cevap: C) Cerrahi el yıkama

Açıklama: Cerrahi el yıkama, mikroorganizmaların cilt yüzeyinde en aza indirilmesini sağlar ve ameliyathane girişinde uygulanır.

6. Soru

El hijyeni için alkol bazlı antiseptikler hangi durumda tercih edilir?

- A) Eller gözle görülür şekilde kirli olduğunda
- B) Tuvalet sonrası
- C) Kan, idrar, dışkı ile temas sonrası
- D) Eller görünür şekilde temiz ancak kontamine olma ihtimali olduğunda
- E) Yemek öncesi

Cevap: D) Eller görünür şekilde temiz ancak kontamine olma ihtimali olduğunda

Açıklama: Eller görünür kirli değilse alkol bazlı antiseptikler tercih edilir.

7. Soru

Kişisel koruyucu ekipman kullanımında (giyinme) doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Eldiven → Maske → Önlük → Gözlük
- B) Maske → Eldiven → Önlük → Gözlük
- C) Önlük → Maske → Gözlük → Eldiven
- D) Gözlük → Eldiven → Önlük → Maske
- E) Maske → Gözlük → Eldiven → Önlük

Cevap: C) Önlük → Maske → Gözlük → Eldiven

Açıklama: Giyme sırası; önce önlük, ardından maske, gözlük ve en son eldivendir. Giyme öncesi el hijyeni”

8. Soru

Tıbbi atık torbaları için doğru uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Siyah renkli ve %100 dolduktan sonra kapatılır
- B) Kırmızı renkli, sızdırmaz ve en fazla 3/4 dolulukta kapatılır
- C) Mavi renkli ve tek kat kullanılır
- D) Sarı renkli ve kesici-delici atıklar için uygundur
- E) Beyaz renkli ve evsel atıklarla birlikte toplanır

Cevap: B) Kırmızı renkli, sızdırmaz ve en fazla 3/4 dolulukta kapatılır

Açıklama: Tıbbi/enfeksiyöz atıklar kırmızı renkli, sızdırmaz torbalarda toplanır; torbalar aşırı doldurulmadan (yaklaşık 3/4 dolulukta) kapatılıp etiketlenir.

9. Soru

Hangi durumda temas izolasyonu uygulanır?

- A) Grip (influenza)
- B) Tüberküloz
- C) Kızamık
- D) MRSA enfeksiyonu
- E) Suçiçeği

Cevap: D) MRSA enfeksiyonu

Açıklama: MRSA gibi dirençli bakterilerin bulaşını önlemek için temas izolasyonu uygulanır.

10. Soru

Damlacık izolasyonu gerektiren hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kızamık
- B) Suçiçeği
- C) Hepatit B
- D) Tüberküloz
- E) Meningokok enfeksiyonu

Cevap: E) Meningokok enfeksiyonu

Açıklama: Damlacık izolasyonu, 1 metreden yakın temasla bulaşan enfeksiyonlarda kullanılır.

YAŞAM BULGULARI ÖLÇÜMÜ

21. Soru

Kan basıncı ölçümü yapılırken manşon hangi seviyede olmalıdır?

- A) Kalp seviyesinden yüksek
- B) Dirsek altı seviyesinde
- C) Kalpten düşük
- D) Omuzdan yüksek
- E) Kalp seviyesinde

Cevap: E) Kalp seviyesinde

Açıklama: Manşon kalp seviyesinde olmalıdır; aksi takdirde yanlış ölçüm alınır.

22. Soru

Hangi ölçüm yöntemi non-invazivdir?

- A) Rektal sıcaklık ölçümü
- B) İntravenöz kateter ile sıcaklık ölçümü
- C) Pulse oksimetre ile oksijen ölçümü
- D) Arteriyel kan gazı ölçümü
- E) Merkezi venöz basınç ölçümü

Cevap: C) Pulse oksimetre ile oksijen ölçümü

Açıklama: Pulse oksimetre, non-invaziv olarak oksijen saturasyonunu ölçer.

23. Soru

Ortalama arter basıncı (OAB) hangi formülle hesaplanır?

- A) $(\text{Sistolik} + \text{Diastolik}) / 2$
- B) $\text{Sistolik} - \text{Diastolik}$
- C) $(\text{Sistolik} + 2 \times \text{Diastolik}) / 3$
- D) $(\text{Sistolik} \times \text{Diastolik}) / 2$
- E) $\text{Sistolik} + \text{Diastolik} \times 2$

Cevap: C) $(\text{Sistolik} + 2 \times \text{Diastolik}) / 3$

Açıklama: Ortalama arter basıncı, organ perfüzyonunu değerlendirmek için hesaplanır.

24. Soru

Vücut sıcaklığının düzenli takibi hangi durumlarda kritik öneme sahiptir?

- A) Kronik hastalıklar, enfeksiyon, postoperatif dönem
- B) Sadece sağlıklı bireylerde
- C) Sadece yaşlılarda
- D) Sadece çocuklarda
- E) Yalnızca acil durumlarda

Cevap: A) Kronik hastalıklar, enfeksiyon, postoperatif dönem

Açıklama: Bu durumlarda vücut sıcaklığının izlenmesi, erken müdahale için kritik öneme sahiptir.

25. Soru

Hiperventilasyon neyi ifade eder?

- A) Solunum sayısının azalması
- B) Tansiyonun düşmesi
- C) Nabızın yavaşlaması
- D) Solunum sayısının artması ve derinleşmesi
- E) Vücut sıcaklığının yükselmesi

Cevap: D) Solunum sayısının artması ve derinleşmesi

Açıklama: Hiperventilasyon, genellikle kaygı veya metabolik durumlar sonucu ortaya çıkar.

26. Soru

Nabız ve kan basıncı ölçümünde hasta hangi pozisyonda olmalıdır?

- A) Sırtüstü, bacaklar yukarıda
- B) Ayakta
- C) Oturur pozisyonda, sırt destekli ve ayaklar yerde
- D) Yalnızca yan yatar pozisyon
- E) Yalnızca oturur, destek yok

Cevap: C) Oturur pozisyonda, sırt destekli

ve ayaklar yerde

Açıklama: Kan basıncı ve nabız ölçümlerinin doğru olması için hasta oturur pozisyonda olmalı, sırtı desteklenmiş ve ayakları yere basmalıdır. Kol kalp seviyesinde desteklenmelidir.

27. Soru

Pulse oksimetre ile SpO_2 %90'ın altında ise hangi durum düşünülmelidir?

- A) Normal
- B) Hipoksemi
- C) Hipotermi
- D) Hipertansiyon
- E) Normotermi

Cevap: B) Hipoksemi

Açıklama: $\text{SpO}_2 < 90\%$, dokulara yeterli oksijen gitmediğini ve hipoksemi olduğunu gösterir.

28. Soru

Vücut sıcaklığı ölçümünde en doğru yöntem hangisidir?

- A) Alından temassız ölçüm
- B) Aksiller ölçüm
- C) Rektal ölçüm
- D) Kulak memesi ölçümü
- E) Koltuk altı ölçümü

Cevap: C) Rektal ölçüm

Açıklama: Rektal ölçüm, vücut çekirdek sıcaklığını en doğru şekilde yansıtır.

29. Soru

Sağlıklı bir yetişkinde normal kabul edilen kan basıncı değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 120/80 mmHg
- B) 140/90 mmHg
- C) 100/60 mmHg
- D) 160/100 mmHg
- E) 90/50 mmHg

Cevap: A) 120/80 mmHg civarı

Açıklama: Sağlıklı yetişkinlerde normal kan basıncı yaklaşık 120/80 mmHg olarak kabul edilir.

30. Soru

Yaşam bulguları ölçümünde kayıt yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus nedir?

- A) Ölçümlerin tahmini kaydedilmesi
- B) Ölçümlerin eksiksiz ve doğru kaydedilmesi
- C) Sadece yüksek değerlerin kaydedilmesi
- D) Hastanın yaşına bakılmadan kaydedilmesi
- E) Ölçüm sıklığının göz ardı edilmesi

Cevap: B) Ölçümlerin eksiksiz ve doğru kaydedilmesi

Açıklama: Yaşam bulgularının doğru ve eksiksiz kaydı, hastanın durum takibi için kritik öneme sahiptir.

STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON

1. Soru

Sterilizasyonun temel tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Mikroorganizmaların sayısını azaltmak
- B) Sadece patojen mikroorganizmaları ortadan kaldırmak
- C) Tüm mikroorganizmaları ve sporları tamamen yok etmek
- D) Enfeksiyon riskini en aza indirmek
- E) Yalnızca yüzeydeki mikropları öldürmek

Cevap: C) Tüm mikroorganizmaları ve sporları tamamen yok etmek

Açıklama: Sterilizasyon; bakteri, virüs, mantar ve bakteri sporları dahil tüm mikroorganizmaların yok edilmesi işlemidir.

2. Soru

Dezenfeksiyon hangi durumlarda yeterli kabul edilir?

- A) Cerrahi aletler için
- B) Kan ile temas eden enjektörler için
- C) Yüzey temizliğinde ve solunum cihazı hortumlarında
- D) İmplant malzemelerinde
- E) Ameliyat öncesi cerrahi malzemelerde

Cevap: C) Yüzey temizliğinde ve solunum cihazı hortumlarında

Açıklama: Dezenfeksiyon, sterilizasyon kadar etkili değildir; sporları öldürmez. Yüzeylerde ve yarı kritik aletlerde kullanılır.

3. Soru

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel sterilizasyon yöntemidir?

- A) Etilen oksit
- B) Formaldehit
- C) Alkol
- D) Glutaraldehit
- E) Otoklav (basınçlı buhar)

Cevap: E) Otoklav (basınçlı buhar)

Açıklama: Fiziksel yöntemler arasında kuru sıcak hava, buhar (otoklav), kaynatma ve radyasyon bulunur.

4. Soru

Otoklav sterilizasyonunda önerilen standart parametreler aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 121°C, 15-20 dakika, 1 bar (15psi) basınç
- B) 80°C, 20 dakika, 1 bar basınç
- C) 100°C, 30 dakika, 2 bar basınç
- D) 110°C, 10 dakika, 2 bar basınç
- E) 90°C, 60 dakika, 1 bar basınç

Cevap: A) 121°C, 15-20 dakika, 1 bar basınç

Açıklama: 121 °C'de 15–20 dakika, 1 bar (15 psi) basınçtır. Alternatif hızlı program ise 134 °C'de 3–5 dakika, 2 bar basınçtır.

5. Soru

Aşağıdaki yöntemlerden hangisi tek başına sterilizasyon sağlamaz?

- A) Kaynatma
- B) Otoklav
- C) Kuru sıcak hava
- D) Radyasyon
- E) Etilen oksit

Cevap: A) Kaynatma

Açıklama: Kaynatma, mikropların çoğunu öldürse de bakteri sporlarına etkili değildir, sterilizasyon değil dezenfeksiyon yöntemidir.

6. Soru

Dezenfeksiyonun seviyeleriyle ilgili doğru eşleşme hangisidir?

- A) Yüksek düzey – Bakteri, virüs, mantar ve tüberküloza etkilidir, bazı sporları da inaktive edebilir
- B) Orta düzey – Tüm sporları öldürür
- C) Düşük düzey – Tüberküloza karşı etkilidir
- D) Yüksek düzey – El antiseptiği olarak kullanılır
- E) Orta düzey – Sadece steril aletlerde uygulanır

Cevap: A) Yüksek düzey – Bakteri, virüs, mantar ve tüberküloza etkilidir, bazı sporları da inaktive edebilir

Açıklama: Yüksek düzey dezenfektanlar (örn. glutaraldehit, OPA) bakteri, virüs, mantar ve tüberküloza etkilidir; bazı spor türlerini inaktive edebilir. Ancak sporların tamamen yok edilmesi için sterilizasyon gerekir.

7. Soru

Aşağıdaki dezenfektanlardan hangisi yüzey temizliğinde en sık kullanılır?

- A) Alkol
- B) Klor bileşikler
- C) Etilen oksit
- D) Formaldehit
- E) Hidrojen peroksit buharı

Cevap: B) Klor bileşikler

Açıklama: Sodyum hipoklorit (çamaşır suyu), hastane yüzey dezenfeksiyonunda en yaygın kullanılan maddedir.

8. Soru

Alkol bazlı el antiseptiklerinde en etkili konsantrasyon aralığı hangisidir?

- A) %20–30
- B) %40–50
- C) %85–90
- D) %60–80
- E) %100 saf alkol

Cevap: D) %60–80

Açıklama: %60–80 etanol veya izopropil alkol el antiseptisinde en etkili konsantrasyondur. Daha yüksek konsantrasyonlarda etkinlik azalır.

9. Soru

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sterilizasyon sadece bakterilere etkilidir, dezenfeksiyon tüm mikroplara etkilidir
- B) Sterilizasyon sporları da öldürür, dezenfeksiyon sporları öldürmez
- C) Sterilizasyon yüzey temizliğinde kullanılır, dezenfeksiyon cerrahi aletlerde kullanılır
- D) Sterilizasyon hızlıdır, dezenfeksiyon yavaştır
- E) İkisi arasında fark yoktur

Cevap: B) Sterilizasyon sporları da öldürür, dezenfeksiyon sporları öldürmez

Açıklama: Sterilizasyon tüm mikroorganizmaları yok ederken dezenfeksiyon sporları ortadan kaldıramaz.

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM

196. Soru

Kalp yetmezliği tanısı ile izlenen 68 yaşındaki bir hastada; ödem, dispne, yorgunluk şikayetleri mevcut. Bu hastaya yönelik hemşirelik süreci planında aşağıdaki hemşirelik tanılarından hangisi önceliklidir?

- A) Bilgi eksikliği
- B) Aktivite intoleransı
- C) Sıvı volüm fazlalığı
- D) Anksiyete
- E) Düşme riski

Cevap: C) Sıvı volüm fazlalığı

Açıklama: Kalp yetmezliğinde ödem, dispne ve kilo artışı öncelikli sorun olan sıvı retansiyonunu gösterir. Bu nedenle “sıvı volüm fazlalığı” hemşirelik tanısı önceliklidir.

197. Soru (Kısa Yanıt)

Hipertansiyon tanısı alan bir hastaya, yaşam tarzı değişiklikleri konusunda hemşirenin vereceği **3 temel öneriyi** yazınız.

- **Cevap:**
- Tuz kısıtlaması (DASH diyeti),
 - Düzenli fiziksel aktivite,
 - Sigara-alkol bırakma.

Açıklama: Hipertansiyon yönetiminde yaşam tarzı değişiklikleri en az ilaç tedavisi kadar önemlidir. Özellikle tuz kısıtlaması ve düzenli egzersiz, kan basıncını düşürmede etkilidir.

198. Soru

Kapak replasmanı ameliyatı olan bir hastanın taburculuk eğitimi sırasında aşağıdaki bilgilerden hangisinin verilmesi **en kritik öneme sahiptir**?

- A) Günlük sıvı alımını artırması
- B) Yara bölgesini her gün antiseptikle temizlemesi
- C) Fiziksel aktiviteden tamamen kaçınması
- D) Düzenli ilaç kullanımının önemi
- E) Egzersiz sırasında nefes tutması

Cevap: D) Düzenli ilaç kullanımının önemi

Açıklama: Kapak replasmanı sonrası özellikle antikoagülan tedavinin düzenli kullanımı hayati önem taşır. İlaçlar aksatılırsa tromboemboli riski artar.

199. Soru (Doğru/Yanlış)

“Kalp hastalarına egzersiz eğitimi verilirken, egzersiz sırasında göğüs ağrısı, baş dönmesi veya nefes darlığı gelişirse derhal egzersize ara verilmesi gerektiği anlatılmalıdır.” DOĞRU/YANLIŞ

Cevap: Doğru

Açıklama: Egzersiz eğitimi, kardiyak rehabilitasyonun önemli bir parçasıdır. Ancak egzersiz sırasında komplikasyon gelişmesi halinde hemen ara verilmelidir.

200. Soru

60 yaşındaki koroner arter hastalığı olan bir hasta, “Artık hiçbir şey yiyemiyorum, ilaçlarım da çok fazla” diyerek tedaviyi reddetme eğilimindedir. Bu durumda hemşirenin **ilk yaklaşımı** aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

- A) Hastayı zorlayarak ilaçlarını içmesini sağlamak
- B) Diyetisyen ve psikolojik destek için yönlendirmek
- C) Hastanın endişelerini anlamak için açık uçlu sorular sormak
- D) Doktor onayı olmadan ilaçları azaltmak
- E) Hastaya diyetin sıkı şekilde uygulanacağını söylemek

Cevap: C) Hastanın endişelerini anlamak için açık uçlu sorular sormak

Açıklama: Hastanın tedavi uyumsuzluğu ile başa çıkabilmek için öncelikle endişelerinin anlaşılması gerekir. İletişim temelli yaklaşım güven ilişkisini güçlendirir.

201. Soru

55 yaşında, hipertansiyon öyküsü olan bir hasta acile göğüs ağrısı, soğuk terleme ve bulantı şikayeti ile başvuruyor. Yapılan EKG’de ST elevasyonu saptanıyor. SpO₂ % 84. Bu durumda hemşirenin **ilk öncelikli girişimi** aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

- A) Hastayı ayağa kaldırıp yürütmek
- B) Subkutan insülin uygulamak
- C) Oksijen desteği sağlamak
- D) Hastaya derin nefes egzersizi yaptırmak
- E) Oral sıvı alımını artırmak

Cevap: C) Oksijen desteği sağlamak

Açıklama: Akut miyokard enfarktüsünde SpO₂ <90 olan veya hipoksemisi bulunan hastalarda oksijen tedavisi önerilir. Bu olguda SpO₂ %84 olduğu için öncelikli hemşirelik girişimi oksijen desteği sağlamaktır.

202. Soru

Kalp yetmezliği nedeniyle izlenen bir hasta, bacaklarda ödem ve gece sık idrara çıkma şikayetleri ile başvuruyor. Bu hastada hemşirenin değerlendirmesi sırasında aşağıdaki bulgulardan hangisi **öncelikli olarak takip edilmelidir**?

- A) Cilt bütünlüğü
- B) Kan basıncı
- C) Günlük kilo takibi
- D) Psikososyal durum
- E) Diyet uyumu

Cevap: C) Günlük kilo takibi

Açıklama: Kalp yetmezliği hastalarında kilo artışı sıvı retansiyonunun en hassas göstergesidir. Bu nedenle günlük tartım en öncelikli izlemidir.

SOLUNUM SİSTEMİ

101. Soru

Trakeostomili hastada sekresyon birikimini önlemek için hemşirelik bakımında öncelikli uygulama hangisidir?

- A) Oral antibiyotik vermek
- B) Oksijen saturasyonunu izlemek
- C) Düzenli aspirasyon ve nemlendirme sağlamak
- D) Kan basıncını ölçmek
- E) Yatak istirahati önerisi

Cevap: C) Düzenli aspirasyon ve nemlendirme sağlamak

Açıklama: Trakeostomi hastalarında sekresyon birikimi tıkanmaya yol açabilir; aspirasyon ve nemlendirme ile hava yolu açıklığı korunur.

102. Soru

Postüral drenaj uygulanan hastada hemşirelik bakımında en önemli nokta aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hastanın sıvı alımını azaltmak
- B) Pozisyon değişimlerini planlı ve kontrollü yapmak
- C) Egzersizleri durdurmak
- D) Oksijen tedavisini kesmek
- E) Antibiyotik dozunu artırmak

Cevap: B) Pozisyon değişimlerini planlı ve kontrollü yapmak

Açıklama: Postüral drenajda pozisyonlama sekresyonların mobilizasyonunu sağlar; uygulama sırasında vital bulgular izlenmelidir.

103. Soru

İnhaler kortikosteroid kullanan hastada hemşire hangi komplikasyonu önlemek için ağız hijyenine dikkat edilmesini önerir?

- A) Diş çürüğü
- B) Oral kandidiyazis
- C) Ağız kuruluğu
- D) Tat alma bozukluğu
- E) Diş eti kanaması

Cevap: B) Oral kandidiyazis

Açıklama: Kortikosteroidler lokal immünsüpresyona neden olabilir; inhalasyon sonrası ağız çalkalanması enfeksiyon riskini azaltır.

104. Soru

Bronşiolit tanısı alan pediatrik hastada hemşirelik bakımında öncelikli uygulama hangisidir?

- A) Antibiyotik başlatmak
- B) Oksijen saturasyonunu izlemek ve nazal O₂ uygulamak
- C) Egzersiz yaptırmak
- D) Sıvı alımını kısıtlamak
- E) Yüksek doz steroid vermek

Cevap: B) Oksijen saturasyonunu izlemek ve nazal O₂ uygulamak

Açıklama: RSV bronşiolitinde hipoksi riski yüksektir; nazal oksijen ve solunum takibi esastır.

105. Soru

Plörezi tanısı alan hastada ağrı nedeniyle yüzeyel solunum gelişirse hemşire hangi uygulamayı önerir?

- A) Derin solunum egzersizleri ve ağrı kontrolü
- B) Egzersiz kısıtlaması
- C) Sıvı alımını azaltma
- D) Antibiyotik kesilmesi
- E) Oksijen tedavisinin durdurulması

Cevap: A) Derin solunum egzersizleri ve ağrı kontrolü

Açıklama: Ağrı nedeniyle yüzeyel solunum atelettazi riskini artırır; analjezi ve solunum egzersizleri ile önlenir.

106. Soru

Respiratuvar asidoz gelişen hastada hemşirelik bakımında öncelikli izlenmesi gereken parametre hangisidir?

- A) Vücut ağırlığı
- B) Kan şekeri
- C) Arteriyel kan gazı değerleri
- D) Hemoglobin düzeyi
- E) Elektrolit paneli

Cevap: C) Arteriyel kan gazı değerleri

Açıklama: Respiratuvar asidozda PaCO₂ artışı ve pH düşüklüğü izlenmelidir; müdahale planı buna göre şekillenir.

107. Soru

Solunum acilinde bilinç değişikliği gelişen hastada hemşirelikte ilk değerlendirme basamağı hangisidir?

- A) Kan şekeri ölçümü
- B) Elektrolit analizi
- C) Solunum hızı ve oksijen saturasyonu
- D) Karın muayenesi
- E) EKG çekimi

Cevap: C) Solunum hızı ve oksijen saturasyonu

Açıklama: Bilinç değişikliği hipoksiye bağlı olabilir; vital bulguların hızlı değerlendirilmesi acil müdahale için kritiktir.

108. Soru

Solunum sistemi hastasında oral sıvı alımının artırılması hangi hemşirelik hedefini destekler?

- A) Hipotansiyonu önlemek
- B) Sekresyonların sulandırılması ve balgam atılımının kolaylaştırılması
- C) Ateşin yükseltilmesi
- D) Dispnenin artırılması
- E) Oksijen saturasyonunun düşürülmesi

Cevap: B) Sekresyonların sulandırılması ve balgam atılımının kolaylaştırılması

Açıklama: Yeterli hidrasyon sekresyon viskozitesini azaltır, öksürükle atılımı kolaylaştırır.

ENDOKRİN

47. Soru

Hipoparatiroidi sonucunda en sık görülen klinik belirti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hipertansiyon B) Tetani C) Hiperglisemi
D) Obezite E) Polidipsi

Cevap: B) Tetani

Açıklama: Hipoparatiroidide kalsiyum düşer; bu da kaslarda istemsiz kasılma (tetani) ve karpopedal spazmlara yol açar.

48. Soru

Kronik böbrek yetmezliğinde sık görülen sekonder hiperparatiroidizmin temel nedeni nedir?

- A) Hipoglisemi B) Hipofosfatemi
C) Hipokalsemi D) Hipernatremi
E) Hiperlipidemi

Cevap: C) Hipokalsemi

Açıklama: Böbrek yetmezliğinde D vitamini aktivasyonu bozulur, kalsiyum düşer, PTH artar → sekonder hiperparatiroidizm gelişir.

49. Soru

Aşağıdakilerden hangisi hiperparatiroidi bulgusu değildir?

- A) Kemiklerde ağrı B) Nefrolitiazis (böbrek taşı)
C) Hiperkalsemi D) Osteoporoz
E) Hiponatremi

Cevap: E) Hiponatremi

Açıklama: Hiperparatiroidide "bones, stones, groans, psychic overtones" (kemik ağrısı, böbrek taşı, karın ağrısı, psikiyatrik bulgular) görülür; sodyum ile ilgisi yoktur.

50. Soru

Chvostek ve Trousseau bulguları hangi durumda tipiktir?

- A) Hiperkalsemi B) Hipokalsemi C) Hipernatremi
D) Hipermağnezemi E) Hiperfosfatemi

Cevap: B) Hipokalsemi

Açıklama: Hipokalsemide nöromusküler iritabilite artar; bu iki bulgu tetani için tanısaldır.

51. Soru

Primer hiperparatiroidinin en sık nedeni nedir?

- A) Paratiroid kanseri B) Paratiroid adenomu
C) Hipofiz tümörü D) Multipl endokrin neoplazi
E) Kronik böbrek yetmezliği

Cevap: B) Paratiroid adenomu

Açıklama: Primer hiperparatiroidi olgularının %85'i paratiroid adenomuna bağlıdır.

52. Soru

Aşağıdaki laboratuvar bulgularından hangisi hipoparatiroidide tipiktir?

- A) Hiperkalsemi – hipofosfatemi
B) Hipokalsemi – hiponatremi
C) Hiperkalsemi – hipernatremi
D) Hipokalsemi – hiperfosfatemi
E) Hipernatremi – hiperkalsemi

Cevap: D) Hipokalsemi – hiperfosfatemi

Açıklama: PTH azaldığında kalsiyum düşer, fosfat yükselir.

53. Soru

Hiperkalsemide sık görülen klinik belirti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Bulantı-kusma B) Diyare
C) Hipereksitabilite D) Epilepsi nöbeti
E) Hipotermi

Cevap: A) Bulantı-kusma

Açıklama: Hiperkalsemide gastrointestinal sistem bulguları (bulantı, iştahsızlık, konstipasyon) sık görülür.

54. Soru

PTH'nın böbrek üzerindeki etkilerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Fosfat geri emilimini artırmak
B) Kalsiyum atılımını artırmak
C) D vitamini aktivasyonunu artırmak
D) Sodyum geri emilimini azaltmak
E) Potasyum atılımını artırmak

Cevap: C) D vitamini aktivasyonunu artırmak

Açıklama: PTH, böbrekte 1 α -hidroksilaz enzimini uyarak D vitaminini aktif hale getirir.

55. Soru

Paratiroid bezinin cerrahi olarak çıkarılmasından sonra en sık gelişen komplikasyon nedir?

- A) Hiperglisemi B) Hipokalsemi C) Hipernatremi
D) Hipopotasemi E) Hipermağnezemi

Cevap: B) Hipokalsemi

Açıklama: Cerrahi sonrası PTH düzeyleri hızla düşer, kalsiyum seviyesi azalır.

56. Soru

Hipoparatiroidiye bağlı kalsiyum düşüklüğünde hangi bulgu beklenmez?

- A) Karpopedal spazm B) Perioral parestezi
C) Tetani D) Ekzoftalmi
E) Kas krampları

Cevap: D) Ekzoftalmi

Açıklama: Ekzoftalmi Graves hastalığına özgüdür, hipokalsemi bulgusu değildir.

57. Soru

Hiperkalsemi tedavisinde ilk adım genellikle aşağıdakilerden hangisidir?

- A) IV sıvı replasmanı B) Kalsiyum takviyesi
C) Hipotermiye neden ilaç D) Diyaliz
E) Kortikosteroid

Cevap: A) IV sıvı replasmanı

Açıklama: Hiperkalsemi acil tedavisinde izotonik sıvı ile hidrasyon yapılır; idrarla kalsiyum atılımı artırılır.

58. Soru

Sekonder hiperparatiroidizmin başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hiperkalsemi B) Kronik böbrek yetmezliği
C) Tiroidit D) Paratiroid adenomu
E) Feokromasitoma

Cevap: B) Kronik böbrek yetmezliği

Açıklama: Böbrek yetmezliğinde D vitamini aktivasyonu azalır, kalsiyum düşer → PTH artışı sekonder hiperparatiroidizm yapar.

GASTROINTESTINAL SİSTEM

46. Soru

Kronik pankreatitte en sık görülen komplikasyon nedir?

- A) Malabsorbsiyon ve diyabet
- B) Hipertansiyon
- C) Hipotiroidi
- D) Osteoporoz
- E) Nefropati

Cevap: A) Malabsorbsiyon ve diyabet

Açıklama: Kronik pankreatitte ekzokrin ve endokrin fonksiyon kaybı malabsorbsiyon ve diyabet gelişimine yol açar.

47. Soru

Kronik karaciğer hastalığında hemşirelik bakımında öncelikli yaklaşım hangisidir?

- A) Diyeti tamamen kısıtlamak
- B) Egzersiz yaptırmak
- C) Vitamin takviyesi yapmak
- D) Hipertansiyonu izlemek
- E) Sıvı ve beslenme desteği sağlamak

Cevap: E) Sıvı ve beslenme desteği sağlamak

Açıklama: Malnütrisyon ve sıvı kaybı riskine karşı uygun beslenme ve sıvı desteği kritik öneme sahiptir.

48. Soru

Akut Hepatit C enfeksiyonu geçiren bireylerde enfeksiyonun kronikleşme olasılığı en yüksek grup hangisidir?

- A) Yetişkinler
- B) Çocuklar
- C) Yeni doğanlar
- D) Adolesanlar
- E) 60 yaş üzeri

Cevap: A) Yetişkinler

Açıklama: Akut Hepatit C enfeksiyonu erişkinlerde yaklaşık %55-85 oranında kronikleşebilir.

49. Soru

Safra yolu enfeksiyonunda en sık görülen semptomlar aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ateş, sağ üst kadranda ağrısı, sarılık
- B) Kabızlık ve baş ağrısı
- C) Dispne ve öksürük
- D) Hipoglisemi ve bulantı
- E) Hipertansiyon ve ödem

Cevap: A) Ateş, sağ üst kadranda ağrısı,

sarılık

Açıklama: Kolanjit üçlüsü (Charcot triadı) tipik bulgudur.

50. Soru

Pankreatitli bir hastada karın ağrısının karakteri genellikle nasıldır?

- A) Sağ alt kadranda hafif ağrı
- B) Diffüz kas ağrısı
- C) Epigastrik ve sırt yönüne yayılan, şiddetli ağrı
- D) Sol üst kadranda keskin ağrı
- E) Baş ağrısı

Cevap: C) Epigastrik ve sırt yönüne

yayılan, şiddetli ağrı

Açıklama: Akut pankreatitte ağrı epigastrik bölgeden başlar ve sırt yönüne yayılır, genellikle yemekle artar.

51. Soru

Karaciğer sirozunda portal hipertansiyon sonucu en sık görülen bulgu hangisidir?

- A) Pulmoner ödem
- B) Böbrek yetmezliği
- C) Özofagus varisleri
- D) Hipertansiyon
- E) Hipotiroidi

Cevap: C) Özofagus varisleri

Açıklama: Portal hipertansiyon, özofagus ve mide varislerinin oluşmasına yol açabilir; kanama riski vardır.

52. Soru

Safra kesesi taşlarının önlenmesinde hemşirelik eğitiminde öncelikli konu hangisidir?

- A) Diyet ve sağlıklı kilo yönetimi
- B) Sıvı kısıtlaması
- C) Vitamin takviyesi
- D) Fiziksel egzersiz yasağı
- E) Antibiyotik kullanımı

Cevap: A) Diyet ve sağlıklı kilo yönetimi

Açıklama: Safra taşları genellikle obezite ve yüksek yağlı diyetle ilişkilidir; yaşam tarzı değişiklikleri önleyici etkindir.

53. Soru

Akut karaciğer yetmezliğinde en ciddi komplikasyon hangisidir?

- A) Hipertansiyon
- B) Ensefalopati
- C) Kabızlık
- D) Hipotiroidi
- E) Diyabet

Cevap: B) Ensefalopati

Açıklama: Karaciğer detoksifikasyon kapasitesi azaldığında amonyak birikir, ensefalopati gelişir.

54. Soru

Kronik pankreatitte en sık vitamin eksikliği hangisidir?

- A) Vitamin B12
- B) Yağda çözünen vitaminler (A, D, E, K)
- C) Folik asit
- D) Vitamin C
- E) Vitamin B1

Cevap: B) Yağda çözünen vitaminler (A, D, E, K)

Açıklama: Pankreas enzim eksikliği yağ emilimini bozar ve yağda çözünen vitaminlerin eksikliğine yol açar.

55. Soru

Akut kolanjitte hemşirelik bakımında öncelikli girişim hangisidir?

- A) Egzersiz yaptırmak
- B) Sıvı kısıtlaması
- C) Antibiyotik tedavisine destek ve vital bulguların izlenmesi
- D) Diyet kısıtlaması
- E) Vitamin takviyesi yapmak

Cevap: C) Antibiyotik tedavisine destek ve

vital bulguların izlenmesi

Açıklama: Kolanjitte enfeksiyon kontrolü kritik olup, antibiyotik tedavisi ile vital bulgular izlenmelidir.

HEMATOLOJİ - ONKOLOJİ

60. Soru:

63 yaşında kadın hasta, ateş, halsizlik ve lenfadenopati ile başvuruyor. CBC'de WBC 15.000/μL, PLT 150.000/μL, Hgb 10 g/dL. Periferik yaymada olgun lenfositler baskın. En olası tanı nedir?

- A) Akut lösemi (ALL)
- B) Multipl miyelom
- C) AML
- D) Demir eksikliği anemisi
- E) Kronik lenfositik lösemi (CLL)

Cevap: E) Kronik lenfositik lösemi (CLL)

Açıklama: Olgun lenfositlerin baskınlığı ve yavaş seyir CLL için tipiktir.

61. Soru:

Kanser hücresinin temel özelliği hangisidir?

- A) Normale yakın diferansiyasyon
- B) Hücre döngüsünü sınırlayan sinyallere normal yanıt
- C) Kontrolsüz hücre bölünmesi
- D) Düşük metabolik aktivite
- E) Apoptoza duyarlılık

Cevap: C) Kontrolsüz hücre bölünmesi

Açıklama: Kanser hücreleri normal hücre döngüsü kontrol mekanizmalarına uymadan çoğalır.

62. Soru:

Onkogenler hangi durumu tetikleyebilir?

- A) Hücre döngüsünün durması
- B) Hücre metabolizmasını yavaşlatma
- C) Apoptoz artışı
- D) Hücre proliferasyonunun artması
- E) DNA tamirini hızlandırma

Cevap: D) Hücre proliferasyonunun artması

Açıklama: Onkogenler hücre bölünmesini artırarak tümör oluşumuna katkı sağlar.

63. Soru:

Tümör baskılayıcı genlerin (tumor suppressor genes) işlevi nedir?

- A) Tümör oluşumunu hızlandırır
- B) Mutasyonu teşvik eder
- C) Hücreyi immün sistemden saklar
- D) Hücre çoğalmasını sınırlar ve apoptozu destekler
- E) Hücre proliferasyonunu artırır

Cevap: D) Hücre çoğalmasını sınırlar ve apoptozu destekler

Açıklama: Tümör baskılayıcı genler kanser gelişimini engelleyen doğal kontrol mekanizmalarıdır.

64. Soru:

Karsinojenler neyi tetikler?

- A) Hücre farklılaşmasını hızlandırır
- B) DNA mutasyonları ve kanser gelişimi
- C) Apoptozu artırır
- D) Hücre döngüsünü durdurur
- E) Metabolizmayı yavaşlatır

Cevap: B) DNA mutasyonları ve kanser gelişimi

Açıklama: Karsinojenler hücre DNA'sında hasara yol açarak tümör oluşumuna zemin hazırlar.

65. Soru:

Metastazın temel mekanizması hangisidir?

- A) Hücre metabolizmasının azalması
- B) Tümörün küçük kalması
- C) Apoptoz artışı
- D) Tümör hücrelerinin kan veya lenf yoluyla uzak organlara yayılması
- E) Hücrelerin daha yavaş çoğalması

Cevap: D) Tümör hücrelerinin kan veya lenf yoluyla uzak organlara yayılması

Açıklama: Metastaz, kanserin lokal sınırları aşarak uzak dokulara yayılmasıdır.

66. Soru:

Angiogenez kanser gelişiminde neden önemlidir?

- A) Tümör boyutunu küçültür
- B) Mutasyonu önler
- C) Tümörün oksijen ve besin kaynağı almasını sağlar
- D) Tümörün immün sistem tarafından yok edilmesini sağlar
- E) Hücre apoptozunu artırır

Cevap: C) Tümörün oksijen ve besin kaynağı almasını sağlar

Açıklama: Yeni damar oluşumu tümörün büyümesini destekler.

67. Soru:

Kanser hücrelerinin apoptoza karşı dirençli olması neyi ifade eder?

- A) Hücre metabolizmasının azalması
- B) Hücre döngüsünün yavaşlaması
- C) Hücrelerin normal ölüm sinyallerine yanıt vermemesi
- D) Hızlı apoptoz
- E) DNA tamirinin artması

Cevap: C) Hücrelerin normal ölüm sinyallerine yanıt vermemesi

Açıklama: Kanser hücreleri, kontrol mekanizmalarının apoptoz sinyallerine direnç gösterir.

68. Soru:

Genetik instabilite kanser gelişiminde nasıl rol oynar?

- A) Apoptozu hızlandırır
- B) Hücre farklılaşmasını destekler
- C) Mutasyon ve karyotip değişikliklerini artırarak tümör oluşumunu kolaylaştırır
- D) Hücre proliferasyonunu azaltır
- E) Metabolizmayı yavaşlatır

Cevap: C) Mutasyon ve karyotip değişikliklerini artırarak tümör oluşumunu kolaylaştırır

Açıklama: Genetik instabilite, kanser hücrelerinde mutasyon birikimini artırır.

BÖBREK VE ÜRİNER SİSTEM

11. Soru

İdrarda lökosit esteraz pozitifliği en çok hangi durumu düşündürür?

- A) Glomerülonefrit
- B) Üriner sistem enfeksiyonu
- C) Diyabetik nefropati
- D) Hipertansiyon
- E) Nefrotik sendrom

Cevap: B) Üriner sistem enfeksiyonu

Açıklama: Lökosit esteraz idrarda lökosit varlığını gösterir ve enfeksiyon için önemlidir.

12. Soru

Böbrek ultrasonografisi genellikle hangi amaçla kullanılır?

- A) Böbrek fonksiyonunu değerlendirmek
- B) Böbrek taşı veya kistleri saptamak
- C) Glomerüler filtrasyon hızını ölçmek
- D) Serum elektrolitlerini değerlendirmek
- E) Eritropoez fonksiyonunu izlemek

Cevap: B) Böbrek taşı veya kistleri saptamak

Açıklama: Ultrason non-invaziv bir yöntem olup böbrek boyutu, kistler ve taşları göstermede kullanılır.

13. Soru

İdrarda proteinüriyi saptamak için kullanılan basit test hangisidir?

- A) Benedict testi
- B) ELISA
- C) Dipstik testi
- D) Western blot
- E) PCR

Cevap: C) Dipstik testi

Açıklama: İdrarda protein varlığını hızlıca gösterebilen tarama yöntemidir.

14. Soru

Böbrek biyopsisinin en önemli endikasyonu hangisidir?

- A) Akut idrar yolu enfeksiyonu
- B) Sebebi açıklanamayan nefrotik sendrom
- C) Akut sistit
- D) Hipertansiyon
- E) Nefrolitiazis

Cevap: B) Sebebi açıklanamayan nefrotik sendrom

Açıklama: Böbrek biyopsisi özellikle nedeni bilinmeyen nefrotik sendrom ve glomerülonefritlerde tanı koydurucudur.

15. Soru

İdrarda mikroskop altında eritrosit silindirlerinin görülmesi hangi tanıyı destekler?

- A) Akut sistit
- B) Piyelonefrit
- C) Glomerülonefrit
- D) Diyabetik nefropati
- E) Prostat hipertrofisi

Cevap: C) Glomerülonefrit

Açıklama: Eritrosit silindirleri glomerül hasarını düşündürür.

16. Soru

Renal travmaların tanısında en sık kullanılan görüntüleme yöntemi hangisidir?

- A) Ultrasonografi
- B) Bilgisayarlı tomografi (BT)
- C) Manyetik rezonans (MR)
- D) Direkt karın grafisi
- E) İntravenöz pyelografi

Cevap: B) Bilgisayarlı tomografi (BT)

Açıklama: Renal travmalarda kontrastlı BT, böbrek parankimi, damar yapısı ve üriner sistem hasarını en iyi gösteren yöntemdir.

17. Soru

Akut böbrek yetmezliğinde en sık görülen neden aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Postrenal obstrüksiyon
- B) Prerenal azotemi
- C) Kronik hipertansiyon
- D) Glomerülonefrit
- E) Polikistik böbrek hastalığı

Cevap: B) Prerenal azotemi

Açıklama: Akut böbrek yetmezliğinin en sık nedeni prerenal azotemidir.

18. Soru

Kronik böbrek yetmezliğinin en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Diabetes mellitus
- B) Glomerülonefrit
- C) Hipertansiyon
- D) Polikistik böbrek
- E) Piyelonefrit

Cevap: A) Diabetes mellitus

Açıklama: Gelişmiş ülkelerde en sık neden diyabetir.

19. Soru

Akut böbrek yetmezliğinde hangi laboratuvar bulgusu tipiktir?

- A) Hipokalemi
- B) Hiponatremi
- C) Hiperkalemi
- D) Hipokalsemi
- E) Hiperglisemi

Cevap: C) Hiperkalemi

Açıklama: Böbrekler potasyum atılımını yapamadığı için hiperkalemi gelişir.

20. Soru

Kronik böbrek yetmezliği hastalarında en sık görülen anemi tipi hangisidir?

- A) Demir eksikliği anemisi
- B) Megaloblastik anemi
- C) Normokrom normositer anemi
- D) Hemolitik anemi
- E) Aplastik anemi

Cevap: C) Normokrom normositer anemi

Açıklama: Eritropoietin eksikliğine bağlı olarak normokrom normositer anemi sık görülür.

BULAŞICI HASTALIKLAR

22. Soru

Hepatit C'nin bulaş yolu en çok aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Cinsel yol
- B) Fekal-oral yol
- C) Parenteral yol (kan ve kan ürünleri)
- D) Solunum yolu
- E) Vektörlerle

Cevap: C) Parenteral yol (kan ve kan ürünleri)

Açıklama: Hepatit C en sık kontamine kan ürünleri ile bulaşır.

23. Soru

Hepatit C için günümüzde kullanılan temel tedavi yöntemi hangisidir?

- A) İnterferon tedavisi
- B) Antiviral direkt etkili ilaçlar (DAA)
- C) Antibiyotik tedavisi
- D) Kortikosteroidler
- E) Aşı uygulaması

Cevap: B) Antiviral direkt etkili ilaçlar (DAA)

Açıklama: Yeni nesil DAA ilaçları ile Hepatit C tedavisinde %95'in üzerinde başarı sağlanmaktadır.

24. Soru

HIV/AIDS'in en önemli bulaş yolu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Damlacık
- B) Fekal-oral
- C) Kan ve cinsel yol
- D) Hava yolu
- E) Vektör

Cevap: C) Kan ve cinsel yol

Açıklama: HIV, en sık cinsel temas ve kontamine kan yoluyla bulaşır.

25. Soru

HIV enfeksiyonunda tanıda en çok kullanılan yöntem hangisidir?

- A) ELISA ve doğrulama için Western Blot / PCR
- B) Kan kültürü
- C) Ultrasonografi
- D) Hemogram
- E) Antijen aşısı

Cevap: A) ELISA ve doğrulama için

Western Blot / PCR

Açıklama: HIV tanısında ilk tarama ELISA ile yapılır, doğrulama Western Blot veya PCR ile olur.

26. Soru

Kan transfüzyonunda bulaşıcı hastalık riskini azaltmak için aşağıdakilerden hangisi zorunludur?

- A) Donör yaşı
- B) Kan grubu tayini
- C) Kan ürünlerinde HBsAg, Anti-HCV ve HIV testleri
- D) Kanın sadece erkeklerden alınması
- E) Kanın dondurularak saklanması

Cevap: C) Kan ürünlerinde HBsAg, Anti-

HCV ve HIV testleri

Açıklama: Kan transfüzyonu güvenliği için Hepatit B, C ve HIV testleri zorunludur.

27. Soru

Kronik Hepatit B hastalarında siroz ve karaciğer kanseri riskini artıran zamanla ilişkili en temel faktör hangisidir?

- A) Kronik enfeksiyonun süresi
- B) Gebelik
- C) Çocukluk çağına geçirilmesi
- D) Parenteral bulaş
- E) Diyet yetersizliği

Cevap: A) Kronik enfeksiyonun süresi

Açıklama: Kronik hepatit B enfeksiyonunun uzun sürmesi siroz ve hepatoselüler karsinom riskini artırır.

28. Soru

Hepatit A'nın en yaygın bulaş yolu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Vektör
- B) Cinsel yol
- C) Kan yolu
- D) Hava yolu
- E) Fekal-oral

Cevap: E) Fekal-oral

Açıklama: Hepatit A özellikle su ve gıdalarla fekal-oral yolla bulaşır.

29. Soru

Hepatit A için en etkili korunma yöntemi hangisidir?

- A) Antiviral ilaç
- B) Aşı
- C) Antibiyotik
- D) Probiyotik
- E) Diyet düzenlemesi

Cevap: B) Aşı

Açıklama: Hepatit A aşısı ile etkin korunma sağlanır.

30. Soru

Tifo hastalığının etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Salmonella typhi
- B) Shigella sonnei
- C) Escherichia coli
- D) Vibrio cholerae
- E) Rotavirüs

Cevap: A) Salmonella typhi

Açıklama: Tifo Salmonella typhi neden olur.

31. Soru

Tifonun en sık bulaş yolu hangisidir?

- A) Kan yolu
- B) Damlacık
- C) Fekal-oral
- D) Cinsel yol
- E) Vektör

Cevap: C) Fekal-oral

Açıklama: Tifo özellikle kontamine su ve gıdalarla fekal-oral yolla bulaşır.

PREOP, İNTRAOP, POSTOP

100. Soru

Postop aspirasyon riskinde en kritik hemşirelik girişimi hangisidir?

- A) İdrar çıkışını izlemek
- B) Havayolunu açık tutmak
- C) Sırtüstü yatırmak
- D) Drenajı takip etmek
- E) Elektrolitleri kontrol etmek

Cevap: B) Havayolunu açık tutmak

Açıklama: Aspirasyonu önlemek için hava yolunun açık tutulması ve lateral pozisyon önemlidir.

101. Soru

Hipoksinin en erken belirtisi hangisidir?

- A) Siyanoz
- B) Bradykardi
- C) Ajitasyon
- D) Solunum sayısında azalış
- E) Terleme

Cevap: C) Ajitasyon

Açıklama: Hipoksinin en erken belirtileri genellikle huzursuzluk, anksiyete ve ajitasyon gibi nörolojik değişikliklerdir. Siyanoz ise daha geç dönemde ortaya çıkan bir bulgudur.

102. Soru

Postop erken dönemde hipotermi komplikasyonlarından biri hangisidir?

- A) Bulantı
- B) Yara ayrılması
- C) Kardiyak aritmi
- D) Aspirasyon
- E) Tromboemboli

Cevap: C) Kardiyak aritmi

Açıklama: Hipotermi kalp ritim bozukluklarına neden olabilir; erken önlem önemlidir.

103. Soru

PACU'da bilincin düzenli değerlendirilmesinde kullanılan ölçek hangisidir?

- A) Apgar
- B) Braden
- C) Norton
- D) Ramsey
- E) Aldrete Skalası

Cevap: E) Aldrete Skalası

Açıklama: PACU da bilinç düzeyini değerlendirmek için en yaygın kullanılan skala Aldrete Skalası'dır.

104. Soru

Postop dönemde kanama şüphesinde ilk yapılacak değerlendirme nedir?

- A) İdrar çıkışı
- B) Ateş ölçümü
- C) Yara yerinin kontrolü
- D) Mobilizasyon
- E) Cilt rengi

Cevap: C) Yara yerinin kontrolü

Açıklama: Kanamanın lokal kaynağını belirlemek için yara alanı hızlıca kontrol edilmelidir.

105. Soru

Hipoksiye bağlı gelişen siyanoz en çok hangi bölgede fark edilir?

- A) Dudak ve tırnak yatağı
- B) Yanak
- C) Karın
- D) Göğüs
- E) Karaciğer

Cevap: A) Dudak ve tırnak yatağı

Açıklama: Siyanoz, hipoksinin geç dönem fizik muayene bulgularından biridir ve en belirgin olarak dudaklar ile tırnak yataklarında fark edilir.

106. Soru

Postop şok gelişen hastada hemşirenin ilk girişimi nedir?

- A) Oral sıvı vermek
- B) Oksijen kesmek
- C) IV sıvı başlatmak
- D) Mobilizasyon yaptırmak
- E) Antiemetik uygulamak

Cevap: C) IV sıvı başlatmak

Açıklama: Şokta dolaşımı stabilize etmek için hızlı IV sıvı verilmelidir.

107. Soru

PACU'da erken dönemde bulantı-kusma gelişen hastada ilk hemşirelik müdahalesi nedir?

- A) Oral sıvı vermek
- B) Lateral pozisyon ve emesis torbası sağlamak
- C) Supine pozisyon
- D) Aktiviteyi artırmak
- E) Analjezi uygulamak

Cevap: B) Lateral pozisyon ve emesis torbası sağlamak

Açıklama: Aspirasyon riskini azaltmak için lateral pozisyon uygulanır.

108. Soru

Tromboemboli gelişme riski yüksek bir hastada hemşirelik önlemi nedir?

- A) Yatak istirahati
- B) Oral sıvı sınırlaması
- C) Kompresyon çorapları ve erken mobilizasyon
- D) Supine pozisyon
- E) Hipotermi sağlamak

Cevap: C) Kompresyon çorapları ve erken mobilizasyon

Açıklama: Tromboemboli profilaksisinde mekanik destek ve mobilizasyon kritik önemdedir.

109. Soru

PACU'da postoperatif bilinç durumu nasıl izlenir?

- A) Sadece konuşma yeteneği ile
- B) İdrar çıkışı ile
- C) Kan basıncı ile
- D) Solunum sayısı ile
- E) Aldrete Skalası

Cevap: E) Aldrete Skalası

Açıklama: PACU da bilinç düzeyini değerlendirmek için en yaygın kullanılan skala Aldrete Skalası'dır.

YARA, DRENLER, STOMA

51. Soru

Dren çıkarıldıktan sonra hemşire hangi uygulamayı yapar?

- A) Dreni tekrar takmak
- B) Steril pansuman ve cilt koruma
- C) Hasta yatakta kalır
- D) Sıvı vermeyi durdurmak
- E) Torbayı boşaltmak

Cevap: B) Steril pansuman ve cilt koruma

Açıklama: Enfeksiyon riskini azaltmak için steril pansuman uygulanır.

52. Soru

Hasta dren bakımı ve drenin önemi hakkında eğitilirken hemşire hangi konuları içermelidir?

- A) Sıvı takibi, dren tıkanıklığı, enfeksiyon belirtileri
- B) Sadece dren torbası markası
- C) Yalnızca dren çıkartma
- D) Ameliyat günleri
- E) Yalnızca mobilizasyon

Cevap: A) Sıvı takibi, dren tıkanıklığı, enfeksiyon belirtileri

Açıklama: Hasta eğitimi multidisipliner ve kapsamlı olmalıdır.

53. Soru

Dren ölçümünü doğru kaydetmek için hangi araç kullanılır?

- A) Steteskop
- B) Termometre
- C) Ölçüm kabı ve kayıt formu
- D) Tansiyon aleti
- E) SpO2 monitörü

Cevap: C) Ölçüm kabı ve kayıt formu

Açıklama: Sıvı miktarının doğru takibi için ölçüm kabı ve kayıt zorunludur.

54. Soru

Dren tıkanıklığı şüphesi varsa ilk yapılacak işlem nedir?

- A) Dreni hafifçe masajla açmak ve hekimi bilgilendirmek
- B) Dreni çıkarmak
- C) Hastayı kaldırmak
- D) Antibiyotik vermek
- E) Torbayı değiştirmemek

Cevap: A) Dreni hafifçe masajla açmak ve hekimi bilgilendirmek

Açıklama: Hafif masaj dreni açabilir, devamında hekim değerlendirmesi gerekir.

55. Soru

Dren yerinde inflamasyon belirtisi olarak hangi bulgu gözlenir?

- A) Solukluk
- B) Kızarıklık, ödem ve ağrı
- C) Cilt kuru
- D) Sıvı renginde değişiklik yok
- E) Dren çalışıyor

Cevap: B) Kızarıklık, ödem ve ağrı

Açıklama: Enfeksiyon ve irritasyon inflamasyon bulgularıdır.

56. Soru

Dren bakımı sırasında hemşirenin kaydetmesi gereken sıvı özellikleri nelerdir?

- A) Hastanın kilosu
- B) Sadece miktar
- C) Sadece rengi
- D) Renk, kıvam, miktar ve kötü koku
- E) Dren markası

Cevap: D) Renk, kıvam, miktar ve kötü koku

Açıklama: Komplikasyon erken fark edilebilmesi için tüm özellikler kaydedilmelidir.

57. Soru

Drenin geri kaçışı engellenmezse hangi durum ortaya çıkabilir?

- A) Dren fazla çalışır
- B) Hızlı iyileşme
- C) Kan basıncı düşer
- D) Sıvı birikimi ve enfeksiyon
- E) Yara küçülür

Cevap: D) Sıvı birikimi ve enfeksiyon

Açıklama: Dren tıkanıklığı veya geri kaçış komplikasyonlara yol açar.

58. Soru

Dren tıkanıklığı fark edildiğinde hemşirenin ikinci adımı ne olmalıdır?

- A) Hekimi bilgilendirmek ve dren durumunu raporlamak
- B) Dreni çıkarmak
- C) Sıvı vermeyi durdurmak
- D) Hastayı yatakta sabitlemek
- E) Torbayı boşaltmamak

Cevap: A) Hekimi bilgilendirmek ve dren durumunu raporlamak

Açıklama: Tıkanıklık durumunda hekim değerlendirmesi gereklidir.

59. Soru

Dren torbası boşaltılırken hemşire hangi önlemi almalıdır?

- A) El hijyeni sağlayıp aseptik teknikle ölçüm kabına boşaltmak
- B) Torbayı doğrudan yere boşaltmak
- C) Torbayı sallamak
- D) Dreni kapatmadan boşaltmak
- E) Ölçüm yapmadan sıvıyı atmak

Cevap: A) El hijyeni sağlayıp aseptik

teknikle ölçüm kabına boşaltmak

Açıklama: Aseptik teknik enfeksiyonu önler, drenaj ölçülüp kaydedilir.

60. Soru

Dren ölçüm ve kayıt sırasında hangi bilgiler kaydedilmelidir?

- A) Hastanın kilosu
- B) Hastanın boyu
- C) Yatak pozisyonu
- D) Dren markası
- E) Miktar, renk, kıvam ve ölçüm zamanı

Cevap: E) Miktar, renk, kıvam ve ölçüm zamanı

Açıklama: Dren sıvısının detaylı kaydı komplikasyonları önler.

YANIK VE TRAVMA

41. Soru

Yanık sonrası gelişebilecek en erken ve ölümcül komplikasyonlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kontraktür
- B) Psikososyal sorunlar
- C) Hipovolemik şok
- D) Böbrek taşları
- E) Skar hipertrofisi

Cevap: C) Hipovolemik şok

Açıklama: Yanık sonrası sıvı kaybına bağlı en erken komplikasyon hipovolemik şoktur.

42. Soru

Spinal travma şüphesi olan bir hasta acile getirildi. Hemşirenin öncelikli uygulaması nedir?

- A) Boyunluk ve spinal immobilizasyon sağlamak
- B) Hastayı oturur pozisyona almak
- C) Yara pansumanı yapmak
- D) Oral sıvı vermek
- E) Hasta yakınını bilgilendirmek

Cevap: A) Boyunluk ve spinal immobilizasyon sağlamak

Açıklama: Spinal travmalarda hareket kısıtlanmalı, hava yolu güvenliği sağlanmalıdır.

43. Soru

Yanık sonrası böbrek yetmezliğine yol açan temel mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Protein kaybı
- B) A vitamini eksikliği
- C) Artan beslenme ihtiyacı
- D) Psikososyal stres
- E) Sıvı-elektrolit dengesizliği ve hipoperfüzyon

Cevap: E) Sıvı-elektrolit dengesizliği ve hipoperfüzyon

Açıklama: Yetersiz sıvı tedavisi böbrek perfüzyonunu bozarak yetmezliğe yol açar.

44. Soru

Yanık hastasında kontraktür gelişimini önlemede hemşirenin rolü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hastayı uzun süre aynı pozisyonda tutmak
- B) Erken mobilizasyon ve eklem hareket açıklığı egzersizleri yaptırmak
- C) Pansumanı geciktirmek
- D) Sadece farmakolojik tedavi uygulamak
- E) Yaranın üzerine baskı yapmak

Cevap: B) Erken mobilizasyon ve eklem hareket açıklığı egzersizleri yaptırmak

Açıklama: Kontraktürleri önlemek için fizyoterapi ve hareket uygulamaları önemlidir.

45. Soru

Yanık sonrası hipertrofik skar gelişimini azaltmak için en uygun yöntem hangisidir?

- A) Alkolle masaj
- B) Basınç giysileri kullanmak
- C) Yara alanını açık bırakmak
- D) Pansumanı sık değiştirmemek
- E) Egzersizden kaçınmak

Cevap: B) Basınç giysileri kullanmak

Açıklama: Basınç giysileri, hipertrofik skar ve kontraktür gelişimini önlemede kullanılır.

46. Soru

Yanık sonrası psikososyal destek gereksinimini en çok artıran faktör hangisidir?

- A) Yanık derinliğinin az olması
- B) Sıvı tedavisinin süresi
- C) Küçük yüzey alanlı yanık
- D) Pansuman sıklığı
- E) Görünür bölgelerde (yüz, el) yanık olması

Cevap: E) Görünür bölgelerde (yüz, el)

yanık olması

Açıklama: Görünümde kalıcı değişiklikler psikolojik etilenmeyi artırır.

47. Soru

Yanık hastasında uzun dönem rehabilitasyonun amaçlarından biri değildir?

- A) Fiziksel fonksiyonları geliştirmek
- B) Psikososyal uyumu desteklemek
- C) Enfeksiyon riskini artırmak
- D) Sosyal hayata uyumu kolaylaştırmak
- E) Mesleki rehabilitasyonu sağlamak

Cevap: C) Enfeksiyon riskini artırmak

Açıklama: Rehabilitasyon, hastanın yaşam kalitesini artırmayı hedefler, komplikasyonları artırmaz.

48. Soru

Yanık sonrası beslenmede en çok artırılması gereken öğe hangisidir?

- A) Karbonhidrat
- B) Protein
- C) Yağ
- D) Vitamin D
- E) Su tuzu

Cevap: B) Protein

Açıklama: Yanık sonrası doku onarımı için protein gereksinimi artar.

49. Soru

Yanık hastasında depresyon riskini azaltmaya yönelik en uygun hemşirelik yaklaşımı hangisidir?

- A) Hastayı yalnız bırakmak
- B) Yalnızca ilaç tedavisi uygulamak
- C) Psikolojik sorunları görmezden gelmek
- D) Hasta ve aileyi bilgilendirmek, desteklemek
- E) Rehabilitasyonu geciktirmek

Cevap: D) Hasta ve aileyi bilgilendirmek, desteklemek

Açıklama: Psikososyal destek, yanık sonrası depresyon riskini azaltır.

50. Soru

Yanık sonrası rehabilitasyon sürecinde hemşirenin en önemli rollerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hastayı tamamen pasif bırakmak
- B) Beslenmeyi kısıtlamak
- C) Egzersizleri sınırlamak
- D) Sosyal destekten uzaklaştırmak
- E) Ekip çalışmasını koordine etmek

Cevap: E) Ekip çalışmasını koordine etmek

Açıklama: Hemşire, rehabilitasyon ekibinde koordinasyon ve hasta eğitimi rolünü üstlenir.

GENEL CERRAHİ

35. Soru

Ameliyat sonrası erken dönemde bulantı-kusmanın en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yara yeri enfeksiyonu
- B) Hipotermi
- C) İlaç dışı alerji
- D) Diyet hatası
- E) Anesteziye bağlı etkiler

Cevap: E) Anesteziye bağlı etkiler

Açıklama: Bulantı-kusma genellikle anestezi ilaçlarının etkisine bağlıdır; antiemetiklerle kontrol sağlanır.

36. Soru

Aşağıdakilerden hangisi postoperatif dönemde şokun en sık nedenidir?

- A) Hipertansiyon
- B) Enfeksiyon
- C) Hipovolemi (kan kaybı)
- D) Elektrolit fazlalığı
- E) Hipotermi

Cevap: C) Hipovolemi (kan kaybı)

Açıklama: Postoperatif şokun en sık nedeni ameliyat sırasında veya sonrasında gelişen kanama ve sıvı kaybıdır.

37. Soru

Ameliyat sonrası dönemde pulmoner emboli riskini azaltmak için en önemli hemşirelik girişimi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yalnızca sıvı alımını artırmak
- B) Yatak istirahatini sürdürmek
- C) Erken mobilizasyon ve bacak egzersizleri
- D) Antihipertansif ilaç uygulamak
- E) Protein ağırlıklı diyet vermek

Cevap: C) Erken mobilizasyon ve bacak egzersizleri

Açıklama: DVT ve emboli riskini azaltmada erken mobilizasyon ve dolaşım egzersizleri kritik öneme sahiptir.

38. Soru

PACU'da ameliyat sonrası ilk saatlerde hemşirenin en öncelikli sorumluluğu hangisidir?

- A) Hastanın ağrı skorunu belirlemek
- B) Sosyal öykü almak
- C) Vital bulguları izlemek ve komplikasyonları erken fark etmek
- D) Pansuman değiştirmek
- E) Hasta eğitimi yapmak

Cevap: C) Vital bulguları izlemek ve komplikasyonları erken fark etmek

Açıklama: Postoperatif erken dönemde vital bulguların takibi komplikasyonların erken saptanmasını sağlar.

39. Soru

Ameliyat sonrası erken dönemde aspirasyon riskini en çok artıran faktör aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yüksek ateş
- B) Yetersiz yutma refleksi
- C) Derin solunum egzersizi
- D) Erken mobilizasyon
- E) Hipotermi

Cevap: B) Yetersiz yutma refleksi

Açıklama: Anestezi sonrası reflekslerin baskılanması aspirasyon riskini artırır; ağızdan beslenmeye geçiş bu nedenle geciktirilir.

40. Soru

Ameliyat sonrası dönemde en sık gözlenen ağrı tipi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Nöropatik ağrı
- B) Kronik ağrı
- C) Fantom ağrı
- D) Psikosomatik ağrı
- E) Akut cerrahi ağrı

Cevap: E) Akut cerrahi ağrı

Açıklama: Postoperatif ağrı genellikle akut karakterdedir ve kontrol edilmezse iyileşmeyi geciktirir.

41. Soru

Yara iyileşmesinin inflamasyon evresi hangi zaman aralığında görülür?

- A) 2-6 ay
- B) 5-10 gün
- C) 10-20 gün
- D) 3-6 hafta
- E) İlk 0-5 gün

Cevap: E) İlk 0-5 gün

Açıklama: İltihap/inflamasyon fazı yara iyileşmesinin ilk basamağıdır; hücresel temizlik ve savunma sağlar.

42. Soru

Proliferasyon evresinde en önemli doku oluşumu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Granülasyon dokusu
- B) Skar dokusu
- C) Fibröz plak
- D) Hematom
- E) Nekrotik doku

Cevap: A) Granülasyon dokusu

Açıklama: Proliferatif fazda fibroblast aktivitesi ile granülasyon dokusu oluşur, yeni damar yapımı başlar.

43. Soru

Primer yara iyileşmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

- A) Yaranın cerrahi dikiş ile kapatılması
- B) Yaranın açık bırakılması
- C) Geniş enfekte alanların bulunması
- D) Granülasyon dokusunun uzun sürede gelişmesi
- E) Sekonder iyileşme sürecine bırakılması

Cevap: A) Yaranın cerrahi dikiş ile kapatılması

Açıklama: Primer iyileşme, dikiş veya stapler ile yara dudaklarının yaklaştırılmasıyla hızlı iyileşmedir.

44. Soru

Sekonder yara iyileşmesinin tipik özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yaranın doğrudan kapatılması
- B) Enfeksiyon olmaması
- C) Geniş doku kaybı ve granülasyon ile kapanma
- D) Minimal skar oluşumu
- E) Kısa sürede epitelizasyon

Cevap: C) Geniş doku kaybı ve granülasyon ile kapanma

Açıklama: Sekonder iyileşmede yara genişir, granülasyon dokusuyla kapanır ve skar belirgindir.

CERRAHİ BRANŞLAR

64. Soru

Üriner kateter takılı bir hastada enfeksiyon riskini azaltmak için hemşire hangi uygulamayı yapmalıdır?

- A) Kateter torbasını yere değdirmek
- B) Kateter bağlantısını gevşetmek
- C) Kateteri aseptik teknikle takmak ve bakımını yapmak
- D) Kateteri günlük değiştirmek
- E) Kateteri hastadan bağımsız hareket ettirmek

Cevap: C) Kateteri aseptik teknikle takmak ve bakımını yapmak

Açıklama: Üriner enfeksiyonu önlemede aseptik teknik kritik öneme sahiptir.

65. Soru

Böbrek taşı cerrahisi sonrası ağrı kontrolünde hemşire hangi yöntemi öncelikli kullanır?

- A) Analjezik tedavi ve ağrı değerlendirmesi
- B) Hipotermi
- C) Kateterin çıkarılması
- D) Uzun süreli yatak istirahati
- E) Diyet kısıtlaması

Cevap: A) Analjezik tedavi ve ağrı değerlendirmesi

Açıklama: Cerrahi sonrası ağrıyı azaltmak için sıcak uygulama ve analjezikler etkin yöntemlerdir.

66. Soru

Prostatektomi sonrası hastada hemşire hangi bulguyu acil bildirmelidir?

- A) Hafif öksürük
- B) Hafif halsizlik
- C) Normal idrar çıkışı
- D) Kısa süreli hafif bulantı
- E) İdrarda kan pıhtısı ve aniden artan ağrı

Cevap: E) İdrarda kan pıhtısı ve aniden artan ağrı

Açıklama: Bu bulgular ciddi komplikasyonu gösterebilir; acil müdahale gerekir.

67. Soru

Nefrostomi sonrası drenaj takibinde hemşire hangi sıklıkta ölçüm yapmalıdır?

- A) Günlük
- B) Haftalık
- C) Önemli değil
- D) Ayda bir
- E) Saatlik veya doktorun önerdiği şekilde

Cevap: E) Saatlik veya doktorun önerdiği şekilde

Açıklama: Drenajın miktarı ve karakteri sürekli izlenmeli, komplikasyonlar erken fark edilmelidir.

68. Soru

Mesane cerrahisi sonrası hastada hemşire hangi durumu fark ederse komplikasyon açısından uyarıcıdır?

- A) Artan hematüri ve ağrı
- B) Normal idrar çıkışı
- C) Hafif halsizlik
- D) Normal ateş
- E) Hafif öksürük

Cevap: A) Artan hematüri ve ağrı

Açıklama: Cerrahi sonrası artan hematüri ve ağrı, hemşirelik açısından erken uyarıcıdır ve takip gerektirir.

GÖZ CERRAHİSİ

69. Soru

Katarakt cerrahisi sonrası hastada hemşire hangi pozisyonu önerir?

- A) Yüz üstü yatış
- B) Tam oturur pozisyon
- C) Sırtüstü yarı oturur pozisyon
- D) Sırt üstü yatış
- E) Yan yatış, operasyon tarafı aşağıda

Cevap: C) Sırtüstü yarı oturur pozisyon

Açıklama: Bu pozisyon ödemi ve hematoma riskini azaltır, hastanın konforunu artırır.

70. Soru

Katarakt cerrahisi sonrası göz damlası kullanımıyla ilgili hemşire hangi uygulamayı uygular?

- A) Günde bir kez tüm damlaları uygular
- B) Aseptik teknikle damlaları uygulanır, kullanım sıklığı doktora göre ayarlanır
- C) Damlaları sulandırarak uygular
- D) Sadece geceleri uygular
- E) Damla uygulamasına gerek yoktur

Cevap: B) Aseptik teknikle damlaları uygulanır, kullanım sıklığı doktora göre ayarlanır

Açıklama: Göz damlası uygulaması enfeksiyon riskini azaltır; hemşire aseptik teknikle uygulamalıdır.

71. Soru

Katarakt cerrahisi sonrası hastada hemşire hangi komplikasyona dikkat etmelidir?

- A) Hipotansiyon
- B) Hiperkalsemi
- C) Ateş düşüklüğü
- D) Hipoglisemi
- E) Göz içi basınç artışı ve enfeksiyon

Cevap: E) Göz içi basınç artışı ve enfeksiyon

Açıklama: Postoperatif dönemde göz içi basıncı ve enfeksiyon riski izlenmelidir.

72. Soru

Glokom cerrahisi sonrası hemşirelik açısından öncelikli izlem aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Solunum sayısı
- B) Nabız sayısı
- C) Göz içi basıncı
- D) Vücut sıcaklığı
- E) İdrar çıkışı

Cevap: C) Göz içi basıncı

Açıklama: Glokom cerrahisi sonrası göz içi basıncı kontrolü komplikasyonların önlenmesinde kritik öneme sahiptir.

73. Soru

Glokom cerrahisi sonrası hemşire hangi belirtiyi acil olarak doktora bildirmelidir?

- A) Hafif kızarıklık
- B) Hafif kaşıntı
- C) Hafif bulanık görme
- D) Göz sulanması
- E) Ani görme kaybı veya ciddi ağrı

Cevap: E) Ani görme kaybı veya ciddi ağrı

Açıklama: Bu bulgular ciddi komplikasyon göstergesi olup derhal müdahale gerektirir.

SIVI-ELEKTROLİT, TRANSFÜZYON, ENFEKSİYON

41. Soru

Hipomagnezemiye bağlı EKG değişikliklerinden hangisi en tipiktir?

- A) PR intervalinde kısalma
- B) QT uzaması ve T dalga düzleşmesi
- C) ST segmentinde yükselme
- D) QRS kompleksinde daralma
- E) P dalgasının kaybolması

Cevap: B) QT uzaması ve T dalga düzleşmesi

Açıklama: Hipomagnezemide QT uzaması, T dalga düzleşmesi ve ventriküler aritmiler görülebilir.

42. Soru

Hipermagnezemi kliniğinde aşağıdakilerden hangisi beklenir?

- A) Tetani ve kas krampları
- B) Reflekslerde artış (hiperrefleksi)
- C) Bradikardi ve derin tendon reflekslerinde azalma
- D) Tremor ve kasılmalar
- E) Hipertansiyon ve taşikardi

Cevap: C) Bradikardi ve derin tendon reflekslerinde azalma

Açıklama: Hipermagnezemide sinir-kas iletimi baskılanır, bradikardi ve hiporefleksi görülür.

43. Soru

Yaşlı bireylerde sıvı-elektrolit dengesizliğinin belirtisi hangisidir?

- A) Hipertansiyon
- B) Dispne
- C) Taşikardi
- D) Ödem
- E) Bilinç değişiklikleri (konfüzyon)

Cevap: E) Bilinç değişiklikleri (konfüzyon)

Açıklama: Yaşlılarda sıvı kaybının en erken bulgusu bilinç bulanıklığıdır, vital bulgular geç değişir.

44. Soru

Dehidratasyonun bebeklerde objektif ve en özgül fiziksel bulgusaşağıdakilerden hangisidir?

- A) Dil kuruluğu
- B) Ciltte soğukluk
- C) Taşikardi
- D) Bingıldakta çökme
- E) Gözyaşının azalması

Cevap: D) Bingıldakta çökme

Açıklama: Bebeklerde dehidratasyonun objektif ve özgül fiziksel bulgularından biri ön fontanelde (bingıldakta) çökmedir.

45. Soru

Kan transfüzyonu sonrası akut solunum sıkıntısı, hipoksemi ve akciğer ödemi gelişmesi hangi komplikasyonu düşündürür?

- A) Febril non-hemolitik reaksiyon
- B) Transfüzyon ilişkili akut akciğer hasarı (TRALI)
- C) Hemolitik reaksiyon
- D) Anafilaksi
- E) Transfüzyon ilişkili dolaşım yüklenmesi (TACO)

Cevap: B) Transfüzyon ilişkili akut akciğer hasarı (TRALI)

Açıklama: TRALI, transfüzyondan sonraki 6 saat içinde gelişen akut akciğer hasarıdır.

46. Soru

Kan transfüzyonu sırasında hipertansiyon, taşikardi ve akciğer ödemi gelişmesi en çok hangi komplikasyonu düşündürür?

- A) Hemolitik reaksiyon
- B) TRALI
- C) Anafilaksi
- D) TACO (Transfüzyon ilişkili dolaşım yüklenmesi)
- E) Septik reaksiyon

Cevap: D) TACO (Transfüzyon ilişkili dolaşım yüklenmesi)

Açıklama: TACO'da dolaşım yüklenmesi sonucu hipertansiyon, akciğer ödemi ve taşikardi görülür.

47. Soru

Eritrosit süspansiyonunun maksimum verilme süresi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 1 saat
- B) 2 saat
- C) 3 saat
- D) 4 saat
- E) 6 saat

Cevap: D) 4 saat

Açıklama: Eritrosit süspansiyonu 30 dakika içinde başlanmalı ve en fazla 4 saatte tamamlanmalıdır.

48. Soru

Kan transfüzyonu için torbadan alınan kan, hastaya başlanmadan önce en geç kaç dakika içinde kullanılmalıdır?

- A) 10 dakika
- B) 20 dakika
- C) 30 dakika
- D) 60 dakika
- E) 90 dakika

Cevap: C) 30 dakika

Açıklama: Kan, soğuk zincirden çıkarıldıktan sonra 30 dakika içinde transfüzyona başlanmalıdır.

49. Soru

Metabolik asidozun solunumsal kompanzasyonu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Bradipne
- B) Hiperventilasyon (Kussmaul solunumu)
- C) Apne
- D) Solunum sayısında değişiklik olmaz
- E) Sadece tidal volüm azalır

Cevap: B) Hiperventilasyon (Kussmaul solunumu)

Açıklama: Metabolik asidozda pH'ı düzeltmek için solunum sistemi CO₂'yi azaltarak kompanzasyon yapar.

50. Soru

Hipokalemi tedavisinde intravenöz potasyum replasmanı yapılırken aşağıdakilerden hangisi hemşirelik açısından en kritik kuraldır?

- A) Hızlı bolus şeklinde uygulanmalıdır
- B) Saatte 10–20 mEq'den fazla verilmemelidir
- C) Potasyum sadece kas içine yapılmalıdır
- D) Potasyum solüsyonu sulandırılmadan uygulanır
- E) Oral yolla uygulanmaz

Cevap: B) Saatte 10–20 mEq'den fazla verilmemelidir

Açıklama: Potasyum damar yolu ile yavaş ve sulandırılarak verilir; hızlı uygulama kardiyak arrest riski taşır.

KARDİYAK ARREST – CPR

TYD (TEMEL YAŞAM DESTEĞİ) - İYD (İLERİ YAŞAM DESTEĞİ)

70. Soru

Post–arrest dönemde hastada epileptik nöbet gelişirse ilk tercih edilen ilaç grubu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Benzodiazepinler
- B) Antidepresanlar
- C) Beta–blokerler
- D) Kalsiyum kanal blokerleri
- E) Antikoagülanlar

Cevap: A) Benzodiazepinler

Açıklama: Post–arrest dönemde nöbet tedavisinde benzodiazepinler ilk tercih edilen ilaçlardır.

71. Soru

Kardiyak arrest sonrası en sık görülen metabolik bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Metabolik alkaloz
- B) Metabolik asidoz
- C) Hipokalemi
- D) Hipernatremi
- E) Hipokalsemi

Cevap: B) Metabolik asidoz

Açıklama: Arrest sırasında anaerobik metabolizma sonucu metabolik asidoz sık görülür.

72. Soru

Kardiyak arrest sonrası ilk 24 saatte en sık ölüm nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hipotermi
- B) Beyin ölümü
- C) Akciğer ödemi
- D) Kardiyak nedenler
- E) Sepsis

Cevap: D) Kardiyak nedenler

Açıklama: Post–arrest ilk 24 saatte kardiyak nedenler en sık ölüm sebebidir.

73. Soru

Post–arrest bakımda hemodinamik destek için tercih edilen ilk sıvı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Albumin
- B) Hipertonik salin
- C) Dextroz %5
- D) Mannitol
- E) İzotonik salin

Cevap: E) İzotonik salin

Açıklama: Post–arrest bakımda ilk tercih edilen sıvı izotonik kristalloittir.

74. Soru

Kardiyak arrest sonrası prognozu en çok belirleyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hastanın kilosu
- B) Kullanılan defibrilatör tipi
- C) Arrestin tanınması ve CPR’nin başlama süresi
- D) Hastanın cinsiyeti
- E) Kullanılan ilaç markası

Cevap: C) Arrestin tanınması ve CPR’nin başlama süresi

Açıklama: Erken CPR prognozu belirleyen en önemli faktördür.

75. Soru

Post–arrest hedef ısı yönetimi en az kaç saat sürdürülmelidir?

- A) 6 saat
- B) 12 saat
- C) 24 saat
- D) 48 saat
- E) 72 saat

Cevap: C) 24 saat

Açıklama: Hedefe yönelik ısı yönetimi en az 24 saat uygulanır.

76. Soru

Kardiyak arrest sonrası hemşirenin rollerinden hangileri doğrudur?

1. Erken tanı ve CPR’ye başlama
 2. Post–arrest dönemde sürekli monitörizasyon
 3. Rehabilitasyon sürecinde mobilizasyon ve komplikasyon önleme
- A) Yalnız 1
 - B) Yalnız 2
 - C) 1 ve 2
 - D) 2 ve 3
 - E) 1, 2 ve 3

Cevap: E) 1, 2 ve 3

Açıklama: Hemşirelik rolü sadece akut dönemde değil, post–arrest bakım ve rehabilitasyon sürecinde de devam eder.

77. Soru

Kardiyak arrest sonrası hemodinamik destek için ilk tercih edilen vazopressör aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Noradrenalin
- B) Dopamin
- C) Adrenalin
- D) Dobutamin
- E) Vazopressin

Cevap: A) Noradrenalin

Açıklama: Post–arrest hipotansiyonda ilk tercih noradrenalinidir.

78. Soru

Kardiyak arrest sonrası hasta hipotermiye alınmışsa hemşirenin izlemesi gereken en önemli parametre aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Vücut ısısı
- B) Göz bebeği çapı
- C) Saç dökülmesi
- D) Cilt kuruluğu
- E) Kas gücü

Cevap: A) Vücut ısısı

Açıklama: Hedefe yönelik hipotermi tedavisinde en kritik izlem parametresi vücut ısısıdır.

79. Soru

Kardiyak arrest sonrası hastada sık görülen solunumsal komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Aspirasyon pnömonisi
- B) Pulmoner emboli
- C) Pnömotoraks
- D) ARDS
- E) Pulmoner fibrozis

Cevap: A) Aspirasyon pnömonisi

Açıklama: Kardiyak arrest sonrası bilinç kaybı ve aspirasyon riski nedeniyle aspirasyon pnömonisi sık görülen solunumsal komplikasyonlardan biridir.

ŞOK, TRAVMA VE ACİL BAKIM

24. Soru: 45 yaşında erkek hasta trafik kazası sonrası acile getiriliyor. Nabız 140/dk, kan basıncı 70/40 mmHg, deri soğuk ve soluk, hemoglobin 6 g/dL. Hangi şok tipi en olasıdır?

- A) Kardiyojenik şok
- B) Obstrüktif şok
- C) Septik şok
- D) Nörojenik şok
- E) Hipovolemik şok

Cevap: E) Hipovolemik şok

Açıklama: Travma sonrası ciddi kan kaybı ve düşük Hb hipovolemik şok düşündürür.

25. Soru:

60 yaşında kadın hasta ateş, hipotansiyon ve taşikardi ile yoğun bakıma yatırılıyor. Laktat düzeyi 5 mmol/L, sıvı tedavisine rağmen hipotansiyon devam ediyor. Bu hasta için en olası tanı nedir?

- A) Hipovolemik şok
- B) Kardiyojenik şok
- C) Anafilaktik şok
- D) Septik şok
- E) Obstrüktif şok

Cevap: D) Septik şok

Açıklama: Sıvı tedavisine dirençli hipotansiyon ve yüksek laktat, sepsis tanısını destekler.

26. Soru

Şokta en erken hemodinamik parametre değişikliği hangisidir?

- A) Santral venöz basınç (CVP) düşmesi
- B) Nabız hızında artış
- C) Kan basıncında düşme
- D) İdrar çıkışında azalma
- E) Oksijen saturasyonunda düşme

Cevap: B) Nabız hızında artış

Açıklama: Şokta ilk görülen kompensatuar yanıt taşikardidir. Hipotansiyon genellikle geç bulgudur.

27. Soru

Şokta santral venöz basınç (CVP) düşüklüğü en çok hangi tip şokta görülür?

- A) Kardiyojenik şok
- B) Hipovolemik şok
- C) Septik şok
- D) Anafilaktik şok
- E) Nörojenik şok

Cevap: B) Hipovolemik şok

Açıklama: Hipovolemik şokta intravasküler hacim kaybı nedeniyle CVP düşer.

28. Soru

Şok hastasında doku perfüzyonunu en iyi gösteren laboratuvar parametresi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hematokrit
- B) Glukoz
- C) Kreatinin
- D) AST/ALT
- E) Laktat düzeyi

Cevap: E) Laktat düzeyi

Açıklama: Yükselen serum laktat düzeyi, hücresel hipoperfüzyonun ve anaerobik metabolizmanın göstergesidir.

29. Soru

Şokta idrar çıkışının değerlendirilmesi için kabul edilen kritik eşik nedir?

- A) <0,3 mL/kg/saat
- B) <0,5 mL/kg/saat
- C) <1 mL/kg/saat
- D) <1,5 mL/kg/saat
- E) <2 mL/kg/saat

Cevap: B) <0,5 mL/kg/saat

Açıklama: Oligüri (<0,5 mL/kg/saat) hipoperfüzyon ve böbrek perfüzyonunun yetersizliğini gösterir.

30. Soru

Septik şokta sıvı resüsitasyonunun temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kan şekeri düzeyini normale getirmek
- B) Vücut ısısını düşürmek
- C) Ortalama arter basıncını (MAP) ≥ 65 mmHg'de tutmak
- D) Hematokriti %50'nin üzerine çıkarmak
- E) Serum sodyumunu yükseltmek

Cevap: C) Ortalama arter basıncını

(MAP) ≥ 65 mmHg'de tutmak

Açıklama: Septik şokta sıvı tedavisinin temel amacı doku perfüzyonunu sağlamak için MAP ≥ 65 mmHg hedeflenmesidir. İzlemede idrar çıkışı (>0,5 mL/kg/saat) ve laktat düzeyinin düşmesi de önemlidir..

31. Soru

Şok yönetiminde ilk tercih edilen sıvı tedavisi hangisidir?

- A) Kolloidler
- B) Kan ürünleri
- C) kristalloidler (Ringer Laktat)
- D) Hipertonik salin
- E) Dekstroz solüsyonu

Cevap: C) kristalloidler

Açıklama: Şok tedavisinde ilk tercih dengeli kristalloid solüsyonlardır (Ringer Laktat veya Plasma-Lyte). Bu sıvılar doku perfüzyonunu sağlamada ve hiperkloremik asidoz riskini azaltmada normal salinden daha avantajlıdır.

32. Soru

Kardiyojenik şokta kardiyak kontraktiliteyi artırmak için en sık tercih edilen inotrop hangisidir?

- A) Adrenalin
- B) Noradrenalin
- C) Dopamin
- D) Dobutamin
- E) Fenilefrin

Cevap: D) Dobutamin

Açıklama: Kardiyojenik şokta kontraktiliteyi artırmak için en sık dobutamin tercih edilir.

33. Soru

Septik şokta vazopressör olarak ilk tercih edilen ilaç hangisidir?

- A) Adrenalin
- B) Fenilefrin
- C) Dopamin
- D) Vasopressin
- E) Noradrenalin

Cevap: E) Noradrenalin

Açıklama: Septik şokta hedef MAP ≥ 65 mmHg için ilk tercih edilen vazopressör noradrenalinidir.

(SSC 2024: Yaşlı ve yüksek riskli hastalarda 70–75 mmHg düşünülebilir. MAP sağlanmazsa vazopressin.)

YOĞUN BAKIMDA HASTA GÜVENLİĞİ

11. Soru

Bası yaralarının değerlendirilmesinde en doğru yöntem hangisidir?

- A) Gözle değerlendirme ve basınç noktalarının palpasyonu
- B) Sadece hastanın şikayetine güvenmek
- C) Yatak çarşafını kaldırmak
- D) Hemşire notlarına bakmak
- E) Hasta yakınıni sorgulamak

Cevap: A) Gözle değerlendirme ve basınç noktalarının palpasyonu

Açıklama: Bası yaraları düzenli gözlem ve palpasyon ile erken tespit edilir. Evreleme (EPUAP/NPUAP) ve Braden skoru ile risk değerlendirilir.

12. Soru

Yoğun bakımda izolasyon önlemleri hangi durumda artırılmalıdır?

- A) Hasta ateşli değilse
- B) Bulaşıcı hastalık varsa
- C) Sadece yeni girişimlerde
- D) Ziyaretçi sayısı fazla ise
- E) Hemşire meşgulse

Cevap: B) Bulaşıcı hastalık varsa

Açıklama: İzolasyon önlemleri bulaşıcı hastalık durumunda artırılmalıdır.

13. Soru

Yoğun bakımda ilaç güvenliğinin sağlanmasında kritik hata önleme yöntemi hangisidir?

- A) Doktor reçetesine güvenmek
- B) İlaç barkod sistemleri ve iki hemşire kontrolü
- C) İlacı hızlı uygulamak
- D) Yalnızca verbal onay almak
- E) Hasta takip etmemek

Cevap: B) İlaç barkod sistemleri ve iki hemşire kontrolü

Açıklama: Barkod sistemleri ve iki hemşire kontrolü ile yanlış ilaç uygulaması riski minimuma indirilir.

14. Soru

Hasta güvenliği kültüründe hemşirelerin liderlik rolü nedir?

- A) Sadece gözlem yapmak
- B) Sorumluluğu doktorlara bırakmak
- C) Riskleri önceden tespit edip ekibi yönlendirmek
- D) Alarm sistemlerini kapatmak
- E) Hasta yakınlarını bilgilendirmemek

Cevap: C) Riskleri önceden tespit edip ekibi yönlendirmek

Açıklama: Hemşireler proaktif rol üstlenerek ekipte güvenlik kültürünü yaygınlaştırır.

15. Soru

Yoğun bakımda enfeksiyon kontrolü için hangi önlem gereklidir?

- A) Tedavi planını değiştirmek
- B) Yalnızca hastayı izlemek
- C) Hasta odasını havalandırmak
- D) Sadece maskeyle müdahale
- E) Standart ve temas izolasyonu, el hijyeni

Cevap: E) Standart ve temas izolasyonu, el hijyeni

Açıklama: Enfeksiyon kontrolünde standart önlemler ve gerektiğinde temas izolasyonu kritik öneme sahiptir.

16. Soru

Bası yaralarının önlenmesinde hangi ekipman kullanılabilir?

- A) Hasta kıyafetleri
- B) Sadece standart yatak
- C) Yatak örtüsü değişimi
- D) Özel bası önleyici yatak ve yastıklar
- E) Hemşire gözlem defteri

Cevap: D) Özel bası önleyici yatak ve yastıklar

Açıklama: Bası yaralarını önlemek için özel yatak ve yastıklar basıncı dağıtır ve riskleri azaltır.

17. Soru

Hasta mahremiyetini sağlamak için hemşire hangi uygulamayı yapmalıdır?

- A) Yalnızca gerekli personelin odada bulunmasını sağlamak
- B) Oda kapısını açık bırakmak
- C) Hasta verilerini paylaşmak
- D) Ziyaretçileri serbest bırakmak
- E) Hasta bakımını azaltmak

Cevap: A) Yalnızca gerekli personelin odada bulunmasını sağlamak

Açıklama: Mahremiyetin sağlanması için gereksiz kişilerin hasta odasında bulunması önlenir.

18. Soru

Yoğun bakımda düşme riskini artıran bir ilaç sınıfı hangisidir?

- A) Antibiyotikler
- B) Vitaminler
- C) Elektrolitler
- D) Antihistaminler
- E) Analjezikler ve sedatifler

Cevap: E) Analjezikler ve sedatifler

Açıklama: Ağrı kesiciler ve sedatifler, koordinasyonu bozarak düşme riskini artırır.

19. Soru

İnvaziv girişimlerde aseptik teknik hangi durumu içermez?

- A) Steril eldiven kullanımı
- B) Steril alan oluşturma
- C) Steril malzeme kullanımı
- D) Steril olmayan eldivenle girişim
- E) Enfeksiyon riskini minimize etme

Cevap: D) Steril olmayan eldivenle girişim

Açıklama: İnvaziv girişimlerde steril olmayan eldiven kullanımı asepsi ihlalidir.

20. Soru

Yoğun bakımda yüksek riskli ilaç uygulamasında hangi uygulama yanlıştır?

- A) İki hemşire kontrolü yapılması
- B) Barkod sistemi kullanılması
- C) Hastaya ilacı uygulamadan önce doğrulama
- D) İlacı hastanın dosyasında kontrol etmeden uygulamak
- E) Doz ve ilacın doğru olup kontrol edilmesi

Cevap: D) İlacı hastanın dosyasında kontrol etmeden uygulamak

Açıklama: Yüksek riskli ilaçlar için mutlaka üçlü kontrol yapılmalı, kontrolsüz uygulama hataya yol açar.

MEKANİK VENTİLATÖR VE MONİTÖRİZASYON

43. Soru

EKG’de nabızsız ventriküler taşikardi saptanan bir hastada hemşirenin ilk yapması gereken adım nedir?

- A) Hastayı izlemeye devam etmek
- B) Acil müdahale çağırmak ve CPR başlatmak
- C) Nabız ölçmek
- D) SpO₂ ayarını artırmak
- E) Tidal volümü artırmak

Cevap: B) Acil müdahale çağırmak ve CPR başlatmak

Açıklama: Ventriküler taşikardi yaşamı tehdit eden aritmidir; acil müdahale hemen başlatılmalıdır.

44. Soru

SpO₂ monitörizasyonunda normal değer aralığı nedir?

- A) 70–79% B) 80–89% C) 95–100%
- D) 100–110% E) 60–69%

Cevap: C) 95–100%

Açıklama: Normal arteriyel oksijen saturasyonu %95–100 arasında olmalıdır.

45. Soru

ETCO₂ monitörizasyonu hangi bilgiyi verir?

- A) Kardiyak debi B) Tidal volüm
- C) Oksijen saturasyonu D) Nabız basıncı
- E) Arteriyel CO₂ düzeyi tahmini

Cevap: E) Arteriyel CO₂ düzeyi tahmini

Açıklama: ETCO₂, alveoler CO₂’yi tahmin eder ve ventilasyon durumunu izlemeye yardımcı olur.

46. Soru

CVP ölçümünde normal değer aralığı nedir?

- A) 0–5 mmHg B) 2–8 mmHg
- C) 10–15 mmHg D) 15–20 mmHg
- E) 20–25 mmHg

Cevap: B) 2–8 mmHg

Açıklama: CVP, sağ atriyum basıncını yansıtır; 2–8 mmHg normal kabul edilir.

47. Soru

İnvaziv arter basıncı dalga formunun sönükleşmesinin en sık nedeni hangisidir?

- A) Kateter tıkanıklığı B) Hipotansiyon
- C) Hiperkapni D) Volutravma
- E) VIP

Cevap: A) Kateter tıkanıklığı

Açıklama: Arter kateteri tıkalıysa basınç yanlış ölçülür; sistem kontrol edilmelidir.

48. Soru

Hemşirenin ventilatör ve monitörizasyon sorumluluklarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Cerrahi işlem yapmak
- B) Radyolojik inceleme yapmak
- C) Kateter yerleştirmek
- D) Ventilatör alarm sistemlerini takip etmek
- E) Tansiyon pompası ayarlamak

Cevap: D) Ventilatör alarm sistemlerini takip etmek

Açıklama: Hemşire, ventilatör ve monitör alarmlarını izleyerek erken müdahale sağlar.

49. Soru

Hangi durumda hemşire ventilatör alarmına anında müdahale etmelidir?

- A) Hastayı pozisyonlamak
- B) FiO₂ değişikliği
- C) Nabız ölçümü
- D) Yüksek havayolu basıncı alarmı
- E) Ateş kontrolü

Cevap: D) Yüksek havayolu basıncı alarmı

Açıklama: Tidal volüm aşımı, barotravma riskini artırır; alarm durumunda hemşire hızlı hareket etmelidir.

50. Soru

Ventilasyon hakkında en iyi bilgi veren monitörizasyon parametresi hangisidir?

- A) ETCO₂
- B) SpO₂
- C) CVP
- D) Nabız
- E) Tidal volüm

Cevap: A) ETCO₂

Açıklama: ETCO₂ alveoler ventilasyonu ve CO₂ atılımını gösterir; oksijenasyon hakkında da dolaylı bilgi verir.

51. Soru

EKG’de bradikardi saptanması hemşire için hangi önlemi gerektirir?

- A) Ateşi ölçmek
- B) Ventilatör ayarını değiştirmek
- C) Tidal volümü artırmak
- D) SpO₂’yi düşürmek
- E) Kardiyak monitör takibi ve acil durum hazırlığı

Cevap: E) Kardiyak monitör takibi ve acil

durum hazırlığı

Açıklama: Bradikardi, hemodinamik instabilite riski taşır; izlem ve acil müdahale gerekir.

52. Soru

SpO₂ %85 olduğunda hemşire hangi önlemi öncelikli olarak almalıdır?

- A) Ateşi ölçmek B) Nabız basıncını ölçmek
- C) Kateter yerleştirmek D) Oksijen desteğini artırmak
- E) Hastayı pozisyonlamak

Cevap: D) Oksijen desteğini artırmak

Açıklama: Düşük SpO₂ hipoksiyi gösterir; oksijen desteği artırılmalıdır.

53. Soru

Ventilasyonun kardiyak output üzerine etkisi ile ilgili doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Pozitif basınçlı ventilasyon sağ atriyum doluşunu artırır
- B) PEEP, venöz dönüşü azaltarak kardiyak outputu düşürebilir
- C) İnspirasyon sırasında preload artar
- D) PEEP, kalp debisini artırır
- E) Ventilasyonun kardiyak etkisi yoktur

Cevap: B) PEEP, venöz dönüşü azaltarak

kardiyak outputu düşürebilir

Açıklama: Yüksek PEEP, hemodinamik baskılanmaya yol açabilir.

ORGAN DESTEK TEDAVİLERİ

31. Soru

Platelet transfüzyonu için hemşire öncelikle hangi parametreyi kontrol eder?

- A) Hasta kimlik doğrulaması ve görsel kontrol
- B) Kan basıncı
- C) Ateş dışında hiçbir şey
- D) Diyet planı
- E) Saç ve tırnak kontrolü

Cevap: A) Hasta kimlik doğrulaması ve görsel kontrol
Açıklama: Hasta kimlik doğrulaması ve ürünün görsel kontrolü ve agregat varlığı kritik önemdedir.

32. Soru

Hemşire kan ürününü hastaya uygularken hangi cihazı kullanmalıdır?

- A) Enjeksiyon şırıngası
- B) Sonda
- C) Oksijen maskesi
- D) Kateter
- E) Transfüzyon seti ve filtreli sistem

Cevap: E) Transfüzyon seti ve filtreli sistem
Açıklama: Kan ürünleri filtreli transfüzyon seti ile uygulanmalıdır; partikül ve trombosit kümelenmesini önler.

33. Soru

Hangi durum kan transfüzyon endikasyonu değildir?

- A) Hafif anemi, stabil hastada Hb 10 g/dL
- B) Hb <7 g/dL ve semptomatik anemi
- C) Akut kan kaybı
- D) Trombositopeni ve kanama riski
- E) Masif travma sonrası hemodinamik instabilite

Cevap: A) Hafif anemi, stabil hastada Hb 10 g/dL
Açıklama: Hafif anemi genellikle transfüzyon gerektirmez; klinik duruma göre karar verilmelidir.

34. Soru

Transfüzyon sırasında hemşire hangi sıklıkta vital bulguları kontrol etmelidir?

- A) Kontrol gerekmez
- B) Sadece başlangıçta
- C) 1 saat sonra
- D) 12 saatte bir
- E) Başlangıçta 15 dk aralıklarla, sonra periyodik olarak

Cevap: E) Başlangıçta 15 dk aralıklarla, sonra periyodik olarak
Açıklama: Transfüzyon reaksiyonları çoğunlukla ilk 15 dakika içinde gelişir; sık izlem hayati öneme sahiptir.

35. Soru

Transfüzyon reaksiyonu geliştiğinde hemşirenin uygulaması gereken ilk adım nedir?

- A) Transfüzyonu durdurmak ve hekimi bilgilendirmek
- B) Hemen yeni ürün hazırlamak
- C) Diyeti değiştirmek
- D) Vital bulgu ölçmemek
- E) Oksijen saturasyonunu artırmak

Cevap: A) Transfüzyonu durdurmak ve hekimi bilgilendirmek
Açıklama: Reaksiyon durumunda hasta güvenliği için transfüzyon hemen durdurulmalı ve hekim bilgilendirilmelidir.

36. Soru

Enteral beslenme endikasyonu nedir?

- A) Tamamen sağlıklı, normal diyetli hasta
- B) Oral beslenmenin yetersiz olduğu ve gastrointestinal sistemin işlevsel olduğu durumlar
- C) Diyabet kontrolü gerekmeyen hasta
- D) Sadece obez hastalar
- E) Sadece pediatrik hasta

Cevap: B) Oral beslenmenin yetersiz olduğu ve gastrointestinal sistemin işlevsel olduğu durumlar
Açıklama: Enteral beslenme, sindirim sistemi çalışıyorsa ve oral alım yetersizse tercih edilir.

37. Soru

Parenteral beslenmede dikkat edilmesi gereken en kritik parametre nedir?

- A) Diyet listesi
- B) Sadece idrar miktarı
- C) Saç ve tırnak kontrolü
- D) Uyku düzeni
- E) Hiperglisemi ve elektrolit dengesizlikleri

Cevap: E) Hiperglisemi ve elektrolit dengesizlikleri
Açıklama: TPN (total parenteral nutrition) uygulamalarında kan şekeri ve elektrolitler sık izlenmelidir.

38. Soru

Enteral beslenme tüpü tıkanmasını önlemek için hemşire ne yapmalıdır?

- A) Diyet listesini değiştirmek
- B) Tüpü asla kontrol etmemek
- C) Sadece hastayı uyarmak
- D) Tüpü düzenli olarak flush yapmak
- E) Vital bulgu takibi yapmak

Cevap: D) Tüpü düzenli olarak flush yapmak
Açıklama: Beslenme tüplerinin tıkanmasını önlemek için steril su ile düzenli flush yapılmalıdır.

39. Soru

TPN uygulamasında hangi komplikasyon en sık görülür?

- A) Saç dökülmesi
- B) Ateş düşüklüğü
- C) Kateter enfeksiyonu
- D) Sadece uyku bozukluğu
- E) Diyet intoleransı

Cevap: C) Kateter enfeksiyonu
Açıklama: Parenteral beslenmede intravenöz kateter enfeksiyonları en sık komplikasyondur; aseptik çok önemlidir.

40. Soru

Enteral beslenme başlatmadan önce hemşire hangi değerlendirmeyi yapmalıdır?

- A) Saç ve tırnak kontrolü
- B) Diyet tercihi
- C) Sadece hasta yaşı
- D) Uyku düzeni
- E) Gastrik residual volüm, abdominal distansiyon ve bulantı

Cevap: E) Gastrik residual volüm, abdominal distansiyon ve bulantı
Açıklama: Enteral beslenme öncesinde gastrointestinal tolerans değerlendirilir. Abdominal distansiyon, bulantı-kusma ve gerektiğinde gastrik rezidü volümü kontrol edilir.

YENİDOĞAN

21. Soru

Yenidoğan muayenesinde aşağıdakilerden hangisi normal bulgudur?

- A) Burun kanatlarının solunuma katılması
- B) Solunum seslerinde inleme
- C) El ve ayaklarda akrosiyanoz
- D) Retraksiyon
- E) Siyanozun tüm vücutta görülmesi

Cevap: C) El ve ayaklarda akrosiyanoz

Açıklama: İlk saatlerde el-ayaklarda akrosiyanoz normal kabul edilir.

22. Soru

Yenidoğanın fizik muayenesinde fontanellerin açık ve düz olması aşağıdakilerden hangisini gösterir?

- A) Normal bulgu
- B) Hidrosefali
- C) Dehidratasyon
- D) İntrakraniyal basınç artışı
- E) Anemi

Cevap: A) Normal bulgu

Açıklama: Fontanellerin açık ve düz olması normaldir; bombelik veya çöküklük patolojik olabilir.

23. Soru

Yenidoğanın ilk değerlendirmesinde hemşirenin öncelikli uygulaması hangisidir?

- A) Anomalileri tespit etmek
- B) Yaşam bulgularını ölçmek
- C) Aileye eğitim vermek
- D) Refleksleri kontrol etmek
- E) Boy ve kilo ölçmek

Cevap: B) Yaşam bulgularını ölçmek

Açıklama: Hemşirenin ilk değerlendirmede öncelikli yenidoğanın yaşam bulgularını değerlendirmektir.

24. Soru

Yenidoğan muayenesinde hepatomegalinin tespit edilmesi hangi durumu düşündürür?

- A) Normal fizyolojik bulgu
- B) Refleks zayıflığı
- C) Fizyolojik sarılık
- D) Akrosiyanoz
- E) Kalp yetmezliği veya enfeksiyon

Cevap: E) Kalp yetmezliği veya enfeksiyon

Açıklama: Yenidoğanda hepatomegali genellikle patolojiktir, kalp yetmezliği veya enfeksiyon düşündürür.

25. Soru

Yenidoğanın Apgar değerlendirmesinde 1. dakikada 5, 5. dakikada 9 puan aldığı görülüyor. Bu durumda doğru yorum hangisidir?

- A) Yenidoğan ağır depresyonda
- B) Normal adaptasyon
- C) Orta depresyonda, ancak hızla toparlanmış
- D) Yeniden canlandırma gereklidir
- E) Riskli bebek izlemine alınmalıdır

Cevap: C) Orta depresyonda, ancak hızla toparlanmış

Açıklama: 1. dakikada 4–6 arası skor orta depresyon (hafif destek gereksinimi olabilir), 5. dakikada 9'a yükselmesi hızlı adaptasyonu gösterir.

26. Soru

Fenilketonüri taraması yenidoğanlarda hangi yöntemle yapılır?

- A) Tükürük örneği
- B) Ağız içi sürüntü
- C) İdrar örneği
- D) Saç teli analizi
- E) Kan örneği (topuk kanı)

Cevap: E) Kan örneği (topuk kanı)

Açıklama: Fenilketonüri, yenidoğanda topuk kanı ile yapılan tarama testleriyle erken dönemde tanımlanır.

27. Soru

Konjenital hipotiroidi taraması için topuk kanı örneği ideal olarak doğumdan sonra kaçinci saatte alınmalıdır?

- A) İlk 6 saat
- B) 48-72 saat
- C) 72 saat
- D) 5. gün
- E) 10. gün

Cevap: B) 48-72 saat

Açıklama: TSH dalgalanması nedeniyle topuk kanının doğumdan sonraki 48–72. saatlerde alınması en güvenilir sonucu verir.

28. Soru

Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanda yapılan metabolik tarama testlerinden biridir?

- A) Tüberkülin testi
- B) PPD testi
- C) ELISA testi
- D) Fenilketonüri testi
- E) Kan grubu tayini

Cevap: D) Fenilketonüri testi

Açıklama: Türkiye'de rutin olarak fenilketonüri, hipotiroidi, biotinidaz eksikliği ve kistik fibrozis için tarama yapılmaktadır.

29. Soru

Yenidoğanda işitme taraması hangi yöntemle yapılır?

- A) Otoakustik emisyon (OAE)
- B) Manyetik rezonans görüntüleme (MR)
- C) Ultrasonografi
- D) Elektrokardiyografi (EKG)
- E) Bilgisayarlı tomografi (BT)

Cevap: A) Otoakustik emisyon (OAE)

Açıklama: Yenidoğanda işitme kaybı taramasında en sık kullanılan yöntem otoakustik emisyon testidir.

30. Soru

Aşağıdakilerden hangisi riskli yenidoğan tanımı içinde yer alır?

- A) Asfiksi öyküsü olan bebek
- B) Term, sağlıklı doğum
- C) Normal doğum kilosu
- D) APGAR skoru 9–10 olan bebek
- E) Sorunsuz gebelik sonrası doğan bebek

Cevap: A) Asfiksi öyküsü olan bebek

Açıklama: Asfiksi, prematüre, düşük doğum ağırlığı, mekonyum aspirasyonu gibi durumlar riskli yenidoğan grubuna girer.

ÇOCUK ACİL VE YOĞUN BAKIM

1. Soru

Çocuklarda kardiyak arrest durumunda ilk yapılması gereken girişim aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İlaç uygulamak
- B) Endotrakeal entübasyon yapmak
- C) Defibrilatör hazırlamak
- D) Damar yolu açmak
- E) Temel yaşam desteğine başlamak

Cevap: E) Temel yaşam desteğine başlamak

Açıklama: Çocuklarda kardiyak arrestte ilk basamak dolaşım ve solunumu sağlamak için temel yaşam desteğine başlamaktır.

2. Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda anafilaktik şokta erken görülen bulgulardan biridir?

- A) Siyanoz
- B) Ciltte kızarıklık ve ürtiker
- C) Bradikardi
- D) Hipotermi
- E) Bilinç kaybı

Cevap: B) Ciltte kızarıklık ve ürtiker

Açıklama: Anafilaksi genellikle ciltte kızarıklık, ürtiker ve kaşıntı ile başlar, ardından solunum ve dolaşım sorunları gelişir.

3. Soru

>1 yaş çocuklarda yabancı cisim aspirasyonunda tam tıkanma varsa hemşirenin ilk yapması gereken uygulama hangisidir?

- A) Sırtına vurmak yerine beklemek
- B) Heimlich manevrası uygulamak
- C) Yüksek doz oksijen vermek
- D) Entübasyon seti hazırlamak
- E) Aspirasyon sondası kullanmak

Cevap: B) Heimlich manevrası uygulamak

Açıklama: Tam tıkanmada en etkin acil girişim Heimlich manevrasıdır. <1 yaşta sırt vuruşu + göğüs basısı yapılır.

4. Soru

Aşağıdaki şok tiplerinden hangisi çocuklarda en sık görülür?

- A) Distribütif şok
- B) Kardiyojenik şok
- C) Hipovolemik şok
- D) Nörojenik şok
- E) Septik şok

Cevap: C) Hipovolemik şok

Açıklama: Çocuklarda en sık görülen şok tipi sıvı kaybına bağlı hipovolemik şoktur.

5. Soru

Metabolik asidoz gelişen çocuk hastada hemşirelik bakımında öncelikli izlemlerden biri hangisidir?

- A) Nörolojik durum
- B) Cilt bütünlüğü
- C) Karın çevresi
- D) Ekstremitte dolaşımı
- E) Göz hareketleri

Cevap: A) Nörolojik durum

Açıklama: Metabolik asidozda bilinç değişiklikleri, letarji ve koma gelişebileceği için nörolojik izlem önceliklidir.

6. Soru

Aşağıdaki bulgulardan hangisi çocukta dekompanse şok göstergesidir?

- A) Taşikardi
- B) Normal kapiller dolum zamanı
- C) Hızlı periferik nabız
- D) Hipotansiyon
- E) Ajitasyon

Cevap: D) Hipotansiyon

Açıklama: Hipotansiyon, çocuklarda şokun geç bulgusudur ve dekompanseasyonu gösterir.

7. Soru

Çocuklarda konvülsiyon sonrası en önemli hemşirelik yaklaşımı hangisidir?

- A) Çocuğu sıkıca tutmak
- B) Ağzına sert bir cisim yerleştirmek
- C) Havayolu açıklığını sağlamak
- D) Hemen damar yolu açmak
- E) Yüksek doz sedatif vermek

Cevap: C) Havayolu açıklığını sağlamak

Açıklama: Konvülsiyon sonrası öncelik, solunum yolu açıklığının korunmasıdır.

8. Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda resüsitasyonda adrenalin uygulama yolu olarak ilk tercih edilmelidir?

- A) Oral
- B) İntramüsküler
- C) Subkutan
- D) İntravenöz
- E) Endotrakeal

Cevap: D) İntravenöz

Açıklama: Çocuklarda resüsitasyonda adrenalin için ilk tercih IV yoldur; mümkün değilse intraosseöz yol kullanılabilir.

9. Soru

Çocuklarda zehirlenme vakalarında en sık görülen zehirlenme tipi hangisidir?

- A) Gıda zehirlenmesi
- B) İlaç zehirlenmesi
- C) Endüstriyel kimyasal zehirlenmesi
- D) Gaz zehirlenmesi
- E) Alkol zehirlenmesi

Cevap: B) İlaç zehirlenmesi

Açıklama: Çocuklarda en sık görülen zehirlenme, evde ulaşılabilen ilaçların yanlış alımıyla gelişir.

10. Soru

Çocuklarda başarılı resüsitasyonun en erken göstergelerinden biri hangisidir??

- A) Pupillerin genişlemesi
- B) Kalp atım hızının artması
- C) Periferik soğukluk
- D) Siyanozun ilerlemesi
- E) Kapiller dolum süresinin uzaması

Cevap: B) Kalp atım hızının artması

Açıklama: Resüsitasyonun etkinliği kalp atım hızı, kapiller dolum süresi, kan basıncı ve oksijenasyon parametreleri birlikte değerlendirilerek belirlenir; kalp hızındaki artış erken göstergelerden biridir.

DEPRESYON, ANKSİYETE, BİPOLAR

40. Soru

Özgül fobilerde tercih edilen ilk basamak tedavi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İlaç tedavisi
- B) Elektrokonvülsif tedavi
- C) Davranışçı terapi (maruz bırakma)
- D) Hipnoterapi
- E) Grup terapisi

Cevap: C) Davranışçı terapi (maruz bırakma)

Açıklama: Özgül fobilerde en etkili yöntem sistematik duyarsızlaştırma ve maruz bırakma terapileridir.

41. Soru

Genelleşmiş anksiyete bozukluğu (GAB) tanısında temel belirti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Belirli bir nesneye karşı korku
- B) Tekrarlayıcı travma anıları
- C) Sürekli ve kontrol edilemeyen kaygı hali
- D) Duygulanımda taşkınlık
- E) Sosyal ortamlarda panik yaşama

Cevap: C) Sürekli ve kontrol edilemeyen kaygı hali

Açıklama: GAB'de kişi günlük yaşam olaylarıyla ilgili sürekli endişe duyar, bu durum en az 6 ay sürer.

42. Soru

Genelleşmiş anksiyete bozukluğu olan bireyde hemşirenin en uygun yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kaygı nedenlerini detaylı tartışmak
- B) Bireye kaygısını bastırmasını söylemek
- C) Gevşeme tekniklerini öğretmek
- D) Kaygıyı pekiştirecek konuşmalara yönelmek
- E) Bireyin yalnız kalmasını sağlamak

Cevap: C) Gevşeme tekniklerini öğretmek

Açıklama: Hemşire, kaygıyı azaltmaya yönelik gevşeme, nefes egzersizi gibi baş etme yöntemlerini öğretmelidir.

43. Soru

Travma sonrası stres bozukluğunda hemşirenin aileye yönelik öncelikli eğitimi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hastanın yalnız bırakılması
- B) Travma hakkında detaylı sorgulama yapılması
- C) Sabır ve destekleyici yaklaşımın sürdürülmesi
- D) Travma anısının sıkça hatırlatılması
- E) Sosyal izolasyon önerilmesi

Cevap: C) Sabır ve destekleyici yaklaşımın sürdürülmesi

Açıklama: TSSB'de aileye, hastaya anlayışlı, yargısız ve destekleyici yaklaşım gösterilmesi gerektiği öğretilir.

44. Soru

Akut stres bozukluğu tanısında belirtiler travmadan sonra en erken ne zaman ortaya çıkar?

- A) Travma anında
- B) 1 hafta sonra
- C) 1 ay sonra
- D) 3 ay sonra
- E) 6 ay sonra

Cevap: A) Travma anında

Açıklama: Akut stres bozukluğu belirtileri travmayı izleyen ilk saatler veya günlerde başlar; erken dönemde gelişir.

BİPOLAR BOZUKLUK

45. Soru

Bipolar bozuklukta temel özellik nedir?

- A) Sadece depresyon atakları
- B) Sosyal fobi
- C) Sürekli kaygı
- D) Panik atak
- E) Depresyon ve mani/hipomani dönemlerinin değişimi

Cevap: E) Depresyon ve mani/hipomani dönemlerinin değişimi

Açıklama: Bipolar bozuklukta hastalar mani veya hipomani dönemleri ile depresyon dönemleri arasında gidip gelir.

46. Soru

Manik dönemde gözlenen belirti hangisidir?

- A) Aşırı üzüntü
- B) Sosyal çekilme
- C) Uyku ihtiyacı artışı
- D) Yalnızlık hissi
- E) Enerji artışı ve taşkın konuşma

Cevap: E) Enerji artışı ve taşkın konuşma

Açıklama: Mani döneminde enerji yükselir, konuşma hızlı ve taşkın olur, riskli davranışlar görülebilir.

47. Soru

Hipomanik dönem ile manik dönem arasındaki temel fark nedir?

- A) Hipomani yalnızca depresyonla görülür
- B) Hipomani daha ağırdır
- C) Hipomani daha kısa sürer ve belirgin işlev kaybına yol açmaz.
- D) Hipomani psikoz içerir
- E) Hipomani tedavi gerektirmez

Cevap: C) Hipomani daha kısa sürer ve belirgin işlev kaybına yol açmaz.

Açıklama: Hipomani hafif ve kısa süreli, manide ise ciddi işlev kaybı ve bazen psikoz görülür.

48. Soru

Bipolar I bozukluk ile Bipolar II bozukluk arasındaki fark nedir?

- A) Bipolar I'de mani atakları, Bipolar II'de hipomani ve depresyon atakları görülür
- B) Bipolar II'de mania vardır
- C) Bipolar I yalnızca depresyon içerir
- D) Bipolar II ağır psikoz içerir
- E) Fark yoktur

Cevap: A) Bipolar I'de mani atakları, Bipolar II'de hipomani ve depresyon atakları görülür

Açıklama: Bipolar I tam mani atakları ile karakterizedir, Bipolar II'de hipomani ve depresyon atakları vardır.

49. Soru

Bipolar bozuklukta mani döneminde hemşirelik yaklaşımı öncelikli olarak ne olmalıdır?

- A) Uykuya müdahale etmek
- B) İzole etmek
- C) Sosyal etkileşimi engellemek
- D) Hasta güvenliğini sağlamak ve riskli davranışları izlemek
- E) Tüm ilaçları kesmek

Cevap: D) Hasta güvenliğini sağlamak ve riskli davranışları izlemek

Açıklama: Mani döneminde hastalar riskli davranış gösterebilir; güvenlik ve izlem önceliklidir.

TOPLUM SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ (HALK SAĞLIĞI)

82. Soru

Bir ülkede son 6 ayda kızamık vakalarında %250 artış gözlenmiştir. Sağlık Bakanlığı, SKA hedefleri doğrultusunda bulaşıcı hastalıkların kontrolü için ulusal bir eylem planı hazırlamaktadır. Planın ilk aşamasında aşağıdaki veriler elde edilmiştir:

- Aşılama oranı: %72 (hedef $\geq$ %95)
- Erken tanı için laboratuvar kapasitesi: %60 doluluk
- Toplumda aşı tereddüdü oranı: %18
- Sağlık çalışanlarının %40'ı son 2 yılda hizmet içi eğitim almamış

➡ Bu veriler ışığında, SKA kapsamında öncelikli olarak uygulanması gereken strateji aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aşı tereddüdünü azaltmaya yönelik toplum temelli eğitim kampanyaları ile eş zamanlı toplu aşılama programı başlatmak
B) Laboratuvar kapasitesini %100'e çıkarmak için altyapı yatırımı yapmak
C) Sağlık çalışanlarının hizmet içi eğitim oranını %90'a yükseltmek
D) Finansal denetim mekanizmalarını güçlendirmek
E) Akademik kurumlarla ortak araştırma projeleri yürütmek

Cevap: A) Aşı tereddüdünü azaltmaya yönelik toplum temelli eğitim kampanyaları ile eş zamanlı toplu aşılama programı başlatmak

Açıklama: SKA'nın "Sağlıklı Bireyler" hedefi kapsamında bulaşıcı hastalıkların kontrolünde en yüksek etki, bağışıklama oranını hızla artırmak ve toplumun aşıya güvenini sağlamakla elde edilir. Laboratuvar kapasitesi ve eğitim yatırımları önemlidir ancak salgın eğrisi yükselirken öncelik bulaş zincirini kırmaktır.

83. Soru

Pandemiler sırasında küresel sağlık kuruluşlarının rolü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Finansal planlama yapmak
B) Salgınları izlemek, rehberlik sağlamak ve ülkeleri desteklemek
C) Akademik not vermek
D) Yalnızca laboratuvar testleri yapmak
E) Sadece aşı üretmek

Cevap: B) Salgınları izlemek, rehberlik sağlamak ve ülkeleri desteklemek

Açıklama: DSÖ ve UNICEF, pandemilerde izleme, rehberlik ve ülkelere teknik destek sağlar.

84. Soru

Bulaşıcı olmayan hastalıklar (diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları) için küresel sağlık stratejisi hangisidir?

- A) Akademik plan yapmak
B) Sadece ilaç üretmek
C) Finansal denetim yapmak
D) Önleme, erken tanı ve yaşam tarzı müdahaleleri
E) Yalnızca gözlem yapmak

Cevap: D) Önleme, erken tanı ve yaşam tarzı müdahaleleri

Açıklama: Kronik hastalıkların kontrolünde önleyici stratejiler kritik öneme sahiptir.

85. Soru

Göç sağlığı kapsamında hem ulusal hem uluslararası kuruluşların önceliği nedir?

- A) Akademik başarıyı izlemek
B) Finansal kaynak sağlamak
C) Sağlık hizmetlerine erişimi sağlamak ve bulaşıcı hastalıkları izlemek
D) Sadece laboratuvar testleri yapmak
E) Yalnızca güvenlik önlemleri almak

Cevap: C) Sağlık hizmetlerine erişimi sağlamak ve bulaşıcı hastalıkları izlemek

Açıklama: Göçmen ve mültecilerin sağlık hizmetlerine erişimi sağlanmalı ve salgın riski izlenmelidir.

86. Soru

Yoksulluk ve sağlık ilişkisi en çok hangi sağlık göstergesi ile ilişkilidir?

- A) Ulaşım altyapısı
B) Finansal yatırım
C) Akademik başarı
D) Laboratuvar testleri
E) Beslenme durumu ve erişilebilir sağlık hizmetleri

Cevap: E) Beslenme durumu ve erişilebilir sağlık hizmetleri

Açıklama: Yoksulluk, sağlık hizmetlerine erişimi ve beslenmeyi olumsuz etkiler.

87. Soru

Türkiye'nin küresel sağlık işbirliğinde DSÖ ve UNICEF ile rolü nedir?

- A) Finansal denetçi
B) Sadece akademik rapor hazırlayıcı
C) Yalnızca laboratuvar testi yapıcı
D) Programların uygulanmasına katkı sağlamak ve uluslararası iş birliği yürütmek
E) Sadece eğitim danışmanı

Cevap: D) Programların uygulanmasına katkı sağlamak ve uluslararası iş birliği yürütmek

Açıklama: Türkiye, ulusal ve uluslararası sağlık programlarını uygulayıcı ve destek sağlayıcı olarak katılır.

88. Soru

UNICEF'in çocuk sağlığı programlarından biri hangisidir?

- A) Finansal raporlama
B) Akademik değerlendirme
C) Altyapı çalışmaları
D) Yalnızca laboratuvar testi
E) Aşılama ve beslenme programları

Cevap: E) Aşılama ve beslenme programları

Açıklama: UNICEF çocuk sağlığını iyileştirmek için aşılama ve beslenme programları yürütür.

89. Soru

SKA/SDG 3. hedefi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Ulaşım güvenliğini artırmayı hedefler
B) Finansal sistemleri güçlendirmeyi hedefler
C) Sadece eğitim hizmetlerini geliştirmeyi hedefler
D) Enerji altyapısını güçlendirmeyi hedefler
E) Herkes için sağlık hizmetlerine erişimi artırmayı ve ölüm oranlarını azaltmayı hedefler

Cevap: E) Herkes için sağlık hizmetlerine erişimi artırmayı ve ölüm oranlarını azaltmayı hedefler

Açıklama: SKA 3, sağlığı geliştirmek ve yaşam süresini uzatmak için evrensel erişimi hedefler.

HEMŞİRENİN İLAÇ UYGULAMA ÖNCESİ DİKKAT EDECEĞİ NOKTALAR (21–30)

21. Soru

İlaç uygulamadan önce hemşirenin yapması gereken ilk adım nedir?

- A) İlacı sulandırmak
- B) Hastanın kimliğini doğrulamak
- C) İlacın dozunu hesaplamak
- D) İlacı yanındaki hastaya da göstermek
- E) İlacın son kullanma tarihini saklamak

Cevap: B) Hastanın kimliğini doğrulamak

Açıklama: İlaç uygulamasında “doğru hasta” ilk basamaktır. Kimlik doğrulama önceliklidir.

22. Soru

Aşağıdakilerden hangisi ilaç uygulama sırasında “doğru” ilkelerinden değildir?

- A) Doğru hasta
- B) Doğru ilaç
- C) Doğru zaman
- D) Doğru ortam
- E) Doğru doz

Cevap: D) Doğru ortam

Açıklama: 8 doğru ilkesi içinde “doğru ortam” yer almaz.

23. Soru

İlaç uygulamadan önce hasta ilacı almak istemezse hemşirenin yapması gereken en doğru yaklaşım nedir?

- A) Zorla ilacı vermek
- B) İlacı saklamak
- C) İlacı çöpe atmak
- D) İlacı hemşire odasında bekletmek
- E) Hastaya bilgi verip hekime bildirmek

Cevap: E) Hastaya bilgi verip hekime bildirmek

Açıklama: Hasta reddi durumunda hem bilgilendirme hem de hekim bildirimi gerekir.

24. Soru

Hemşire ilaç uygulamadan önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka kontrol etmelidir?

- A) İlacın rengi hoş mu
- B) İlacın fiyatı
- C) İlacın son kullanma tarihi
- D) İlacın kim tarafından yazıldığı
- E) İlacın marka ismi

Cevap: C) İlacın son kullanma tarihi

Açıklama: Uygulama öncesi SKT mutlaka kontrol edilmelidir.

25. Soru

İlaç uygulamalarında “doğru kayıt” ilkesi hangi durumda gerçekleştirilmiş olur?

- A) İlacın rengi deftere yazıldığında
- B) İlaç uygulandıktan sonra kaydedildiğinde
- C) İlacın fiyatı dosyaya işlendiğinde
- D) İlaç uygulamadan önce kaydedildiğinde
- E) İlacın yan etkileri kayıtsız bırakıldığında

Cevap: B) İlaç uygulandıktan sonra kaydedildiğinde

Açıklama: Doğru kayıt uygulamadan hemen sonra yapılır.

26. Soru

İlaç uygulamadan önce hemşirenin hastadan öğrenmesi gereken bilgi nedir?

- A) Ailesinde meslek seçimi
- B) İlaça karşı bilinen alerjisi
- C) Hastanın sosyal durumu
- D) Hastanın dini inanışı
- E) Hastanın eğitim seviyesi

Cevap: B) İlaça karşı bilinen alerjisi

Açıklama: Alerji öyküsü ilaç güvenliği için kritik bir bilgidir.

27. Soru

Aşağıdakilerden hangisi ilaç uygulama öncesi yapılmaz?

- A) Eller hijyenik şekilde yıkanır
- B) İlacın etiketi okunur
- C) Doğru doz hesaplanır
- D) İlacın tadına bakılır
- E) Hastanın kimliği doğrulanır

Cevap: D) İlacın tadına bakılır

Açıklama: Hemşire ilacın tadına bakmaz.

28. Soru

İlaç uygulaması öncesinde hastaya bilgi vermenin temel amacı nedir?

- A) Hasta hemşireye güvensin diye
- B) Hekimi memnun etmek için
- C) Hasta katılımını ve güvenini sağlamak
- D) İlacı daha hızlı uygulamak
- E) Yan etkileri azaltmak

Cevap: C) Hasta katılımını ve güvenini

sağlamak

Açıklama: Bilgilendirme hasta güvenliği ve uyumunu artırır.

29. Soru

İlacın uygulanacağı yol hekim isteminde belirtilmemişse hemşire ne yapmalıdır?

- A) İlacı bekletir ve hekime danışır
- B) İstem dışı uygulama yapar
- C) Kendi bildiği gibi uygular
- D) İlacı çöpe atar
- E) Başka bir hemşireye sorar

Cevap: A) İlacı bekletir ve hekime danışır

Açıklama: Hekim istemi net değilse hemşire uygulama yapmaz.

30. Soru

İlaç uygulama öncesi “doğru zaman” ilkesine göre, ilaç ne zaman verilmelidir?

- A) İsteddiği zaman
- B) Hasta talep edince
- C) Servis uygun olduğunda
- D) Hemşirenin iş yoğunluğu bitince
- E) Hekim isteminde belirtilen saatlere uygun

Cevap: E) Hekim isteminde belirtilen

saatlere uygun

Açıklama: Doğru zaman, hekim istemine göre uygulanır.

HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA VE YÖNETİM

31. Soru

Kanıtı dayalı uygulamada hemşirenin rolü nedir?

- A) Sadece araştırma yapmak
- B) Kanıtların geçerliliğini sorgulamamak
- C) Kanıtları klinik uygulamaya entegre etmek
- D) Yalnızca teorik bilgi vermek
- E) Hasta görüşlerini dikkate almamak

Cevap: C) Kanıtları klinik uygulamaya entegre etmek

Açıklama: Hemşirenin temel görevi kanıtları hasta bakımına uyarlamaktır.

32. Soru

Kanıtı dayalı uygulamada “kanıt” hangi unsurlardan elde edilir?

- A) Sadece hemşirelik teorilerinden
- B) Sadece randomize çalışmalar
- C) Yalnızca doktor görüşlerinden
- D) Klinik deneyim, hasta tercihleri ve araştırmalardan
- E) Yalnızca gözlemsel çalışmalar

Cevap: D) Klinik deneyim, hasta tercihleri ve araştırmalardan

Açıklama: Kanıt, üç temel kaynaktan beslenir: araştırma, deneyim, hasta değerleri.

33. Soru

Kanıtı dayalı uygulama sürecinde kanıtların değerlendirilmesi neden önemlidir?

- A) Uygulama maliyetini azaltmak için
- B) Sadece teoriyi geliştirmek için
- C) Araştırmanın güvenilirliğini ve geçerliliğini sorgulamak için
- D) Hemşirelik eğitimini kolaylaştırmak için
- E) Hasta görüşlerini yok saymak için

Cevap: C) Araştırmanın güvenilirliğini ve geçerliliğini sorgulamak için

Açıklama: Kanıtların güçlü ve güvenilir olup olmadığı değerlendirilmelidir.

34. Soru

Kanıtı dayalı hemşireliğin yaygınlaşmasını engelleyen faktörlerden biri değildir:

- A) Zaman yetersizliği
- B) Yeterli bilgiye ulaşamama
- C) Araştırma okuryazarlığının düşük olması
- D) Araştırma sonuçlarını uygulamaya yansıtma
- E) Kurumsal destek eksikliği

Cevap: D) Araştırma sonuçlarını uygulamaya yansıtma

Açıklama: Araştırma sonuçlarını uygulamaya yansıtmak engel değil, hedeftir.

35. Soru

Kanıtı dayalı uygulamada literatür taraması yapılırken kullanılan kaynaklardan biri hangisidir?

- A) Güncel bilimsel dergiler
- B) Kişisel bloglar
- C) Sosyal medya paylaşımları
- D) Popüler kitaplar
- E) Deneyimsel olmayan kaynaklar

Cevap: A) Güncel bilimsel dergiler

Açıklama: Literatür taramasında güncel bilimsel dergiler ve güvenilir bilimsel veri tabanları temel bilgi kaynaklarıdır.

36. Soru

Kanıtı dayalı uygulama sürecinde klinik deneyimin önemi nedir?

- A) Hiçbir önemi yoktur
- B) Kanıtların uygulanabilirliğini artırır
- C) Araştırma sonuçlarını geçersiz kılar
- D) Hasta görüşlerini gereksiz kılar
- E) Yalnızca teorik bilgi sağlar

Cevap: B) Kanıtların uygulanabilirliğini artırır

Açıklama: Klinik deneyim, araştırma sonuçlarının pratiğe uyarlanmasını kolaylaştırır.

37. Soru

Kanıtı dayalı hemşirelikte hasta tercihleri neden dikkate alınır?

- A) Eğitim süresini kısaltmak için
- B) Araştırma sonuçlarını değiştirmek için
- C) Kanıt düzeyini yükseltmek için
- D) Klinik deneyimi geçersiz kılmak için
- E) Hasta uyumunu artırmak için

Cevap: E) Hasta uyumunu artırmak için

Açıklama: Hasta tercihleri dikkate alındığında bakım sürecine katılım artar.

38. Soru

Kanıtı dayalı uygulamanın hasta güvenliği üzerine etkisi nedir?

- A) Riskleri azaltır
- B) Yan etkileri artırır
- C) Komplikasyonları görmezden gelir
- D) Klinik hataları artırır
- E) Hasta memnuniyetini azaltır

Cevap: A) Riskleri azaltır

Açıklama: Kanıtı dayalı uygulama, hasta güvenliği için riskleri azaltır.

39. Soru

Kanıtı dayalı hemşirelik uygulamalarında araştırma sonuçlarının pratiğe aktarılması süreci ne olarak adlandırılır?

- A) Araştırma geliştirme
- B) Bilgi yönetimi
- C) Araştırma-uygulama entegrasyonu
- D) Klinik deneyim
- E) Teorik aktarım

Cevap: C) Araştırma-uygulama entegrasyonu

Açıklama: Araştırma bulgularının klinik uygulamaya aktarılmasına entegrasyon denir.

40. Soru

Kanıtı dayalı uygulamalarda hemşirelerin en sık yaşadığı sorunlardan biri hangisidir?

- A) Fazla bilimsel veri
- B) Zaman yetersizliği
- C) Hasta isteksizliği
- D) Klinik deneyim fazlalığı
- E) Eğitim kaynaklarının fazlalığı

Cevap: B) Zaman yetersizliği

Açıklama: Hemşirelerin klinikte en sık yaşadığı engel zaman yetersizliğidir.

Teşekkür Ederim

Bu ön izleme dosyasını inceleyerek kitabıma zaman ayırdığınız için teşekkür ederim.

Bu kaynak, özellikle Hac Sağlık Sınavına hazırlanan hemşireler için uzun bir çalışma sürecinin sonunda hazırlanmıştır.

Kitabın tamamına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.



Hemşirelik Soru Bankası

HAC Sağlık Sınavı'na hazırlanan adaylar için hazırlanmış, kapsamlı ve özgün bir kaynaktır.

Klinik bilgi, temel hemşirelik, dahiliye, cerrahi, kadın doğum, çocuk sağlığı, psikiyatri, halk sağlığı, yönetim, etik, farmakoloji, yoğun bakım ve acil hemşireliği gibi tüm temel ve uzmanlık alanlarını kapsayan 3679 özgün soru içerir.

Sorular; güncel kaynaklar, klinik uygulamalar ve hemşirelik deneyimi temel alınarak titizlikle hazırlanmıştır.

Bu kitap, hem bilgi düzeyini ölçmek ve profesyonel düşünme becerisini geliştirmek, hem de HAC sınavına hazırlanmak isteyen hemşireler için güçlü bir sınav rehberidir.



ISBN: 978-625-00-6555-6

© 2025 Musa Akat - Tüm hakları saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz.